AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

CIRUGÍA GENERAL

Abdomen Agudo & Anestesia

21 temas · 1 página cada uno · 7 días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Abdomen Agudo Quirúrgico

★★☆ 11.1. Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía 3
★★☆ 11.2. Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap GES 5
★☆☆ 11.3. Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx 6
★★★ 11.4. Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer 7
★★★ 11.5. Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo) 9

02 Pared Abdominal, Hernias & Proctología

★★☆ 11.6. Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones GES 10
★★★ 11.7. Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas 11
★★★ 11.8. Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas 12
★★☆ 11.19. Patología Vascular Periférica: Aneurismas, Várices e Insuficiencia Venosa & Úlceras de las Piernas 13
★☆☆ 11.20. Obesidad Mórbida y Cirugía Bariátrica: Indicaciones, Técnicas y Complicaciones 15

03 Politraumatizado, Cirugía de Urgencia & Quemaduras (ATLS)

★★★ 11.9. Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) GES 16
★★★ 11.10. Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante GES 17
★★☆ 11.11. Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia GES 19
★★☆ 11.12. Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC GES 21
★★☆ 11.13. Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES GES 22

04 Preoperatorio, Anestesia & Complicaciones Quirúrgicas

★☆☆ 11.14. Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios 24
★☆☆ 11.15. Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales 25
★★★ 11.16. Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs) 26
★☆☆ 11.17. Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda 27
★★☆ 11.18. Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica GES 28
★☆☆ 11.21. Procedimientos de Cirugía Menor: Punción Venosa, Manejo de Drenajes, Onicocriptosis & Onicectomía 29

Números que tienes que saber 30
Fármacos de primera línea 32
GES de la especialidad 32
Plan de repaso de 7 días 34
Índice por prioridad ★ 35

BLOQUE 01 · ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

11.1 Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad en el EUNACOM · Causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico no traumático

4.01.2.006 Apendicitis aguda — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

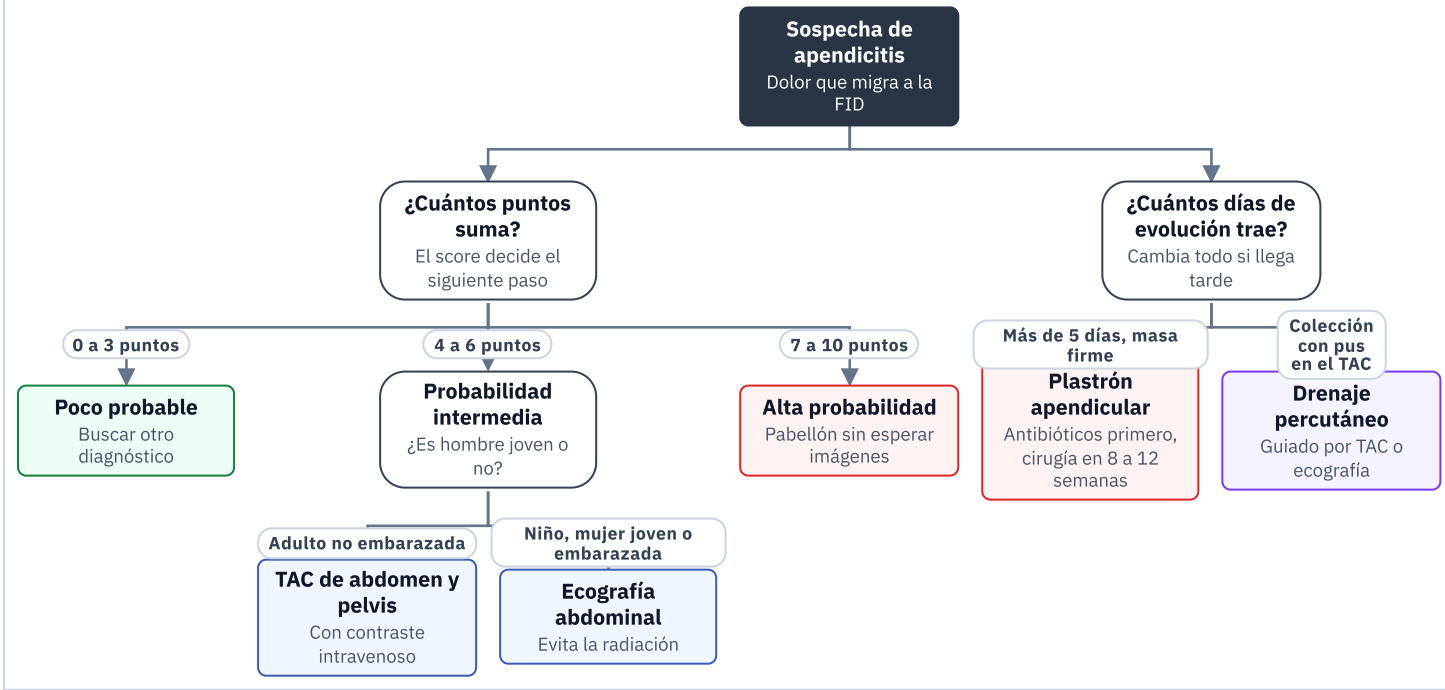
LO QUE TE PREGUNTAN

- La cronología de Murphy (dolor periumbilical que migra a FID tras **6-12 horas**) es el patrón clínico más específico de apendicitis aguda.
- Score de Alvarado **≥ 7 en** varones jóvenes con clínica típica permite indicar apendicectomía directa sin necesidad de TAC previo.
- El TAC de abdomen y pelvis con contraste IV es el estándar de oro diagnóstico en ancianos, adultos con presentación atípica o score intermedio (4-6 puntos).
- En embarazadas, niños pequeños y mujeres jóvenes, la ecografía abdominal es el estudio inicial obligado para evitar radiación ionizante.
- El plastrón apendicular flemoso no complicado se maneja inicialmente con tratamiento médico conservador (antibióticos EV) y apendicectomía electiva diferida (de intervalo) en **8-12 semanas**.
- Si el plastrón presenta un absceso fluctuante **≥ 3-4 cm**, el tratamiento de elección es el drenaje percutáneo guiado por TAC o ecografía + antibióticos.
- En apendicitis no perforada, la profilaxis antibiótica es de DOSIS ÚNICA preoperatoria; prolongar antibióticos postoperatorios es un error frecuente y sancionado en el EUNACOM.



FECALITO EN LA FID
Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 158

ALGORITMO · APENDICITIS AGUDA: DEL DOLOR AL PABELLÓN



PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **46–48, 65, 67** (págs. 21, 24) · solucionario págs. 35, 37–38.

Clase 11.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

11.1 Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 11.1 · SCORE DE ALVARADO (MANTRELS) Y CONDUCTA CLÍNICA ESTANDARIZADA

COMPONENTE MANTRELS	CRITERIO CLÍNICO / LABORATORIO	PUNTAJE	CONDUCTA SEGÚN ESTRATO
Migración del dolor	Dolor que inicia periumbilical y migra a FID	1 punto	Puntaje 0 – 3: Muy baja probabilidad; evaluar diagnósticos alternativos y alta con pautas
Anorexia	Pérdida de apetito o intolerancia alimentaria	1 punto	Puntaje 4 – 6: Probabilidad intermedia; observación clínica activa + TAC con contraste (o Eco)
Náuseas / Vómitos	Vómitos alimentarios o náuseas persistentes	1 punto	Puntaje 7 – 8: Alta probabilidad; preparación quirúrgica y apendicectomía (TAC si duda)
Tenderness (Dolor FID)	Dolor a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha	2 puntos	Puntaje 9 – 10: Certeza diagnóstica casi absoluta; pabellón directo sin demora por imágenes
Rebote (Blumberg)	Dolor a la descompresión brusca parietal en FID	1 punto	Nota: En mujeres fértiles, niños y ancianos, la neuroimagen es mandatoria con score ≥ 4
Elevación térmica	Temperatura axilar ≥ 37.3 °C (subfebril o febril)	1 punto	Analgesia: Los AINE u opioides NO enmascaran el examen físico y deben indicarse precozmente
Leucocitosis	Recuento de leucocitos > 10.000 células/mm³	2 puntos	Hemograma y PCR son sensibles pero inespecíficos; valor predictivo negativo alto
Shift (Neutrofilia)	Bastonados / Neutrófilos segmentados ≥ 75%	1 punto	Total máximo: 10 puntos (Puntaje ≥ 7 tiene sensibilidad > 85% para apendicitis aguda)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hombre joven, Alvarado 7 a 10	Apendicectomía directa	Pedir TAC antes de operar
Mujer en edad fértil o niño	Ecografía primero	Pedir TAC de entrada
Plastrón flemoso, sin colección	Antibióticos y cirugía diferida	Operar de urgencia

REGLA DE ORO **Alvarado 7 a 10** — Pabellón directo, sin imágenes

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica más frecuente del mundo. Su patogenia es la obstrucción de la luz apendicular por un fecalito, hiperplasia linfoide o parásitos, provocando proliferación bacteriana, estasis venosa, isquemia parietal, necrosis y perforación. El diagnóstico en hombres jóvenes con clínica clásica es estrictamente clínico. La demora diagnóstica más allá de 24-36 horas eleva drásticamente la tasa de perforación (de <5% a >30%), flemón, absceso periapendicular y peritonitis generalizada.

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **46–48, 65, 67** (págs. 21, 24) · solucionario págs. 35, 37–38.

Clase 11.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

11.2 Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

4.01.2.011 Colecistitis aguda — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Litiasis biliar · Ecografía: distinguir vesícula y líquido intraabdominal · Colecistitis crónica

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Colecistitis aguda** = dolor continuo en HCD > **6 horas** + Murphy (+) + fiebre/leucocitosis + pared engrosada en ecografía.
- El signo de Murphy ecográfico positivo (dolor al presionar la vesícula con el transductor) es el hallazgo ecográfico más específico.
- La bilirrubina elevada > **4 mg/dL** NO es propia de colecistitis aislada y obliga a descartar coledocolitiasis o Síndrome de Mirizzi.
- El estándar de tratamiento para colecistitis aguda Grado I y II es la colecistectomía laparoscópica precoz dentro de **72 horas**.
- En pacientes críticos con Grado III (falla orgánica hemodinámica, respiratoria o renal) o riesgo quirúrgico prohibitivo, la conducta es colecistostomía percutánea.



CÁLCULOS CON SOMBRA ACÚSTICA
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 44

ALGORITMO · COLECISTITIS AGUDA: DEL DIAGNÓSTICO A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

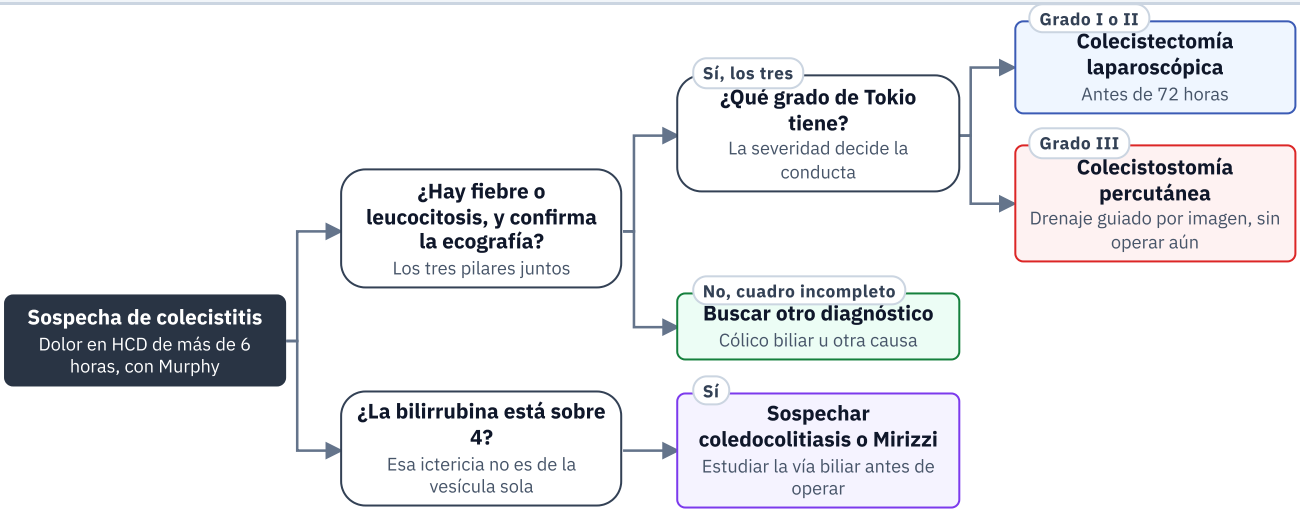


TABLA 11.2 · GUÍAS DE TOKIO 2018 (TG18) — CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE COLECISTITIS AGUDA

CATEGORÍA DE CRITERIOS	PARÁMETROS ESPECÍFICOS EVALUADOS	REQUISITO PARA SOSPECHA	REQUISITO PARA CERTEZA
A. Inflamación Local	1) Signo de Murphy clínico (+) · 2) Dolor o masa palpable en HCD	Un ítem de A	Un ítem de A
B. Inflamación Sistémica	1) Fiebre > 38 °C · 2) Leucocitosis > 10.000/mm³ · 3) PCR elevada	Un ítem de B	Un ítem de B
C. Hallazgos de Imagen	Litiasis impactada, pared ≥ 4 mm, líquido perivesicular, Murphy eco (+)	No requiere	Confirmación por C
Conclusión Diagnóstica	Sensibilidad diagnóstica > 90%; especificidad > 85%	Diagnóstico Sospechoso (A + B)	Diagnóstico Definitivo (A + B + C)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Cólico biliar: sin fiebre, Murphy negativo	Analgesia y colecistectomía electiva derivada	Tratarlo como colecistitis aguda
Grado I o II, estable	Colecistectomía laparoscópica antes de 72 h	Diferir la cirugía a semanas
Grado III o riesgo anestésico prohibitivo	Colecistostomía percutánea	Operar igual, a toda costa

REGLA DE ORO **Los tres pilares de Tokio** — Los tres juntos confirman

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **7, 38, 56, 62, 70** (págs. 14, 19, 22–24) · solucionario págs. 30, 34, 36–38.

Clase 11.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

11.3 Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx

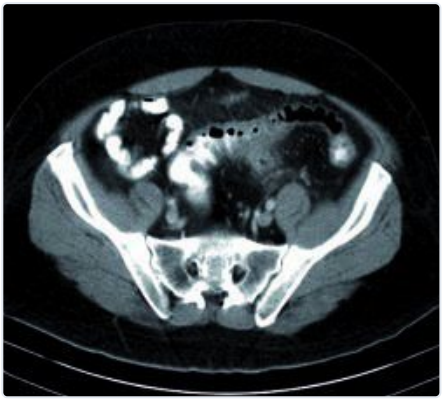
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

4.01.2.008 **Enfermedad diverticular complicada** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: TAC de abdomen y pelvis · Enfermedad diverticular no complicada · Colostomías

LO QUE TE PREGUNTAN

- La diverticulitis aguda ocurre por microperforación diverticular en el colon sigmoides y se presenta con dolor en FII, fiebre y Blumberg (+).
- El TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso es el examen de primera línea obligatorio para diagnosticar y etapificar según Hinchey.
- La colonoscopía está FORMALMENTE CONTRAINDICADA en la fase aguda por riesgo inminente de perforación barométrica libre.
- Abscesos diverticulares **≥ 4 cm** (Hinchey II) se manejan de elección con drenaje percutáneo guiado por TAC + antibióticos endovenosos.
- Abscesos pequeños < **3-4 cm** (Hinchey Ib) responden exitosamente a tratamiento médico exclusivo con antibióticos endovenosos.



DIVERTICULITIS EN TAC
Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 142

ALGORITMO · DIVERTICULITIS AGUDA: DEL TAC A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 11.3 · CLASIFICACIÓN DE HINCHEY MODIFICADA Y ALGORITMO TERAPÉUTICO ESCALONADO

ESTADIO HINCHEY	HALLAZGOS PATOLÓGICOS / TOMOGRÁFICOS	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA DE ELECCIÓN	CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN / CIRUGÍA
Hinchey 0	Diverticulitis clínica; engrosamiento parietal sin flemón	Manejo médico ambulatorio; analgesia y dieta líquida	Hospitalizar solo si intolerancia oral o comorbilidad
Hinchey Ia	Flemón o inflamación pericólica confinada a mesocolon	Hospitalización, reposo intestinal, ATB endovenosos	Ceftriaxona + Metronidazol EV; respuesta > 90%
Hinchey Ib	Absceso pericólico o mesocólico pequeño (< 4 cm)	Antibioticoterapia EV parenteral exclusiva	Vigilancia tomográfica si hay persistencia febril
Hinchey II	Absceso a distancia pélvico o retroperitoneal (≥ 4 cm)	Drenaje percutáneo guiado por TAC + ATB EV	Evita colostomía de urgencia; resección electiva diferida
Hinchey III	Peritonitis purulenta generalizada sin contenido fecal libre	Laparotomía urgente: Operación de Hartmann o resección + ileo	Cirugía inmediata con lavado peritoneal y UCI
Hinchey IV	Peritonitis fecaloidea generalizada por perforación macroscópica	Operación de Hartmann de urgencia + Resucitación intensiva	Mortalidad 20-30%; lavado profuso y soporte en UPC

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Sospecha de diverticulitis aguda	TAC de abdomen y pelvis con contraste	Pedir colonoscopía para confirmar
Cierre de la colostomía	A los 3 a 6 meses, tras estudiar el segmento excluido	Cerrar sin colonoscopía ni enema previo
Alta tras el episodio agudo	Colonoscopía a las 6 a 8 semanas	No estudiar más el colon

REGLA DE ORO **Rosado, húmedo y brillante** — Pálido, violáceo o negro: isquemia

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **71, 73** (págs. 24–25) · solucionario págs. 38–39.

Clase 11.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

11.4 Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

★★★
PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

Máxima frecuencia histórica en EUNACOM · Pregunta angular de urgencias quirúrgicas con 12 reconstrucciones oficiales

`4.01.2.005` **Obstrucción Intestinal** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Radiografía simple de abdomen · TAC de abdomen y pelvis

LO QUE TE PREGUNTAN

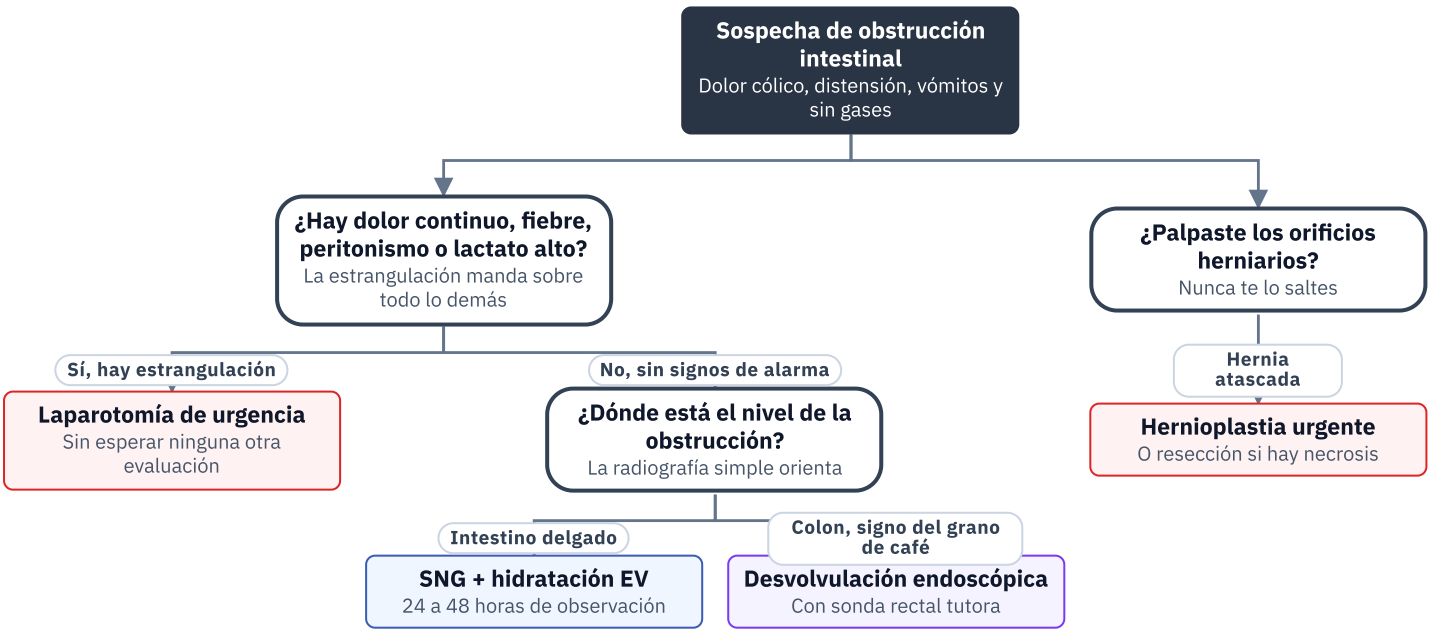
- La causa más frecuente de obstrucción de intestino delgado son las bridas postoperatorias (**60-70%**); en colon es el cáncer colorrectal (**60%**).
- El tetraedro de la obstrucción es dolor cólico, vómitos, distensión abdominal y detención de gases y heces.
- En intestino delgado sin estrangulación, el manejo inicial es MÉDICO CONSERVADOR con Sonda Nasogástrica y fluidos EV por **24-48 horas**.
- Signos de estrangulación (dolor continuo, fiebre, taquicardia, peritonismo, leucocitosis, acidosis láctica) exigen laparotomía inmediata.
- El vólvulo de sigmoides muestra el signo del "grano de café" y se maneja inicialmente con desvolvulación endoscópica si no hay necrosis.
- **Siempre palpar orificios herniarios**: la hernia crural atascada es una causa típica y grave de obstrucción en mujeres añosas.
- En obstrucción colónica en asa cerrada con válvula continente, un diámetro cecal > **10-12 cm** indica riesgo inminente de perforación diastásica.



NIVELES HIDROAÉREOS
Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 163

ALGORITMO · OBSTRUCCIÓN INTESTINAL: DE LA CLÍNICA A LA CIRUGÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **8–17, 49, 55** (págs. 14–16, 21–22) · solucionario págs. 30–31, 35–36.

Clase 11.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

11.4 Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 11.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO DELGADO VS OBSTRUCCIÓN DE COLON

CARACTERÍSTICA CLÍNICA / RADIOLÓGICA	OBSTRUCCIÓN INTESTINO DELGADO (ALTA)	OBSTRUCCIÓN DE COLON (BAJA)	VÓLVULO DE SIGMOIDES
Etiología principal	Bridas postquirúrgicas (60-70%), hernias (20%)	Cáncer colorrectal (60%), diverticulitis (10%)	Rotación sigmoidea sobre su meso elongado (chagas, dieta)
Dolor abdominal	Cólico periumbilical precoz y muy frecuente	Cólico en hipogastrio o flancos, insidioso	Dolor cólico que se torna sordo en hemiabdomen izquierdo
Vómitos	Precoces, abundantes, biliosos a porráceos	Tardíos o ausentes; fecaloideos en fase avanzada	Tardíos; náuseas precedentes
Distensión abdominal	Discreta o moderada; central	Severa, marcada, periférica en marco	Masiva, asimétrica, timpanismo marcado
Radiografía simple	Asas centrales en escalera con válvulas conniventes	Marco colónico dilatado con haustras periféricas	Signo del "grano de café" o asa en omega nacida en FII
Manejo de primera línea	Médico conservador (SNG + Sueros) x 24-48 h	Quirúrgico según etiología (o stent colónico)	Desvolvulación endoscópica urgente + sonda rectal

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Bridas, sin estrangulación	SNG + hidratación EV, 24 a 48 h	Laparotomía inmediata
Vólvulo no complicado	Desvolvulación endoscópica	Cirugía de entrada
Dolor continuo, fiebre, lactato alto	Laparotomía urgente, sin demora	Seguir con manejo conservador

REGLA DE ORO **Delgado: bridas y hernias** — Colon: cáncer y vólvulo

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La obstrucción intestinal mecánica representa hasta el 20% de todos los ingresos por abdomen agudo. Su etiología depende críticamente del segmento comprometido: en el intestino delgado, las bridas o adherencias postoperatorias son la causa más frecuente (60-70%), seguidas por las hernias atascadas; en el colon, el cáncer colorrectal encabeza la lista (60%), seguido por el vólvulo de sigmoides (20%). El mayor desafío clínico es diagnosticar precozmente el sufrimiento de asa (estrangulación), el cual transforma un cuadro médico-quirúrgico electivo en una urgencia de laparotomía inmediata por riesgo de necrosis y perforación.

TABLA 11.4.B · MANEJO MÉDICO CONSERVADOR VS OPCIONES QUIRÚRGICAS SEGÚN ETIOLOGÍA

PATOLOGÍA / ESCENARIO	TRATAMIENTO INICIAL DE ELECCIÓN	CRITERIOS DE FRACASO / CONVERSIÓN	PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DEFINITIVO
Bridas No Estranguladas	SNG a caída libre + Ringer Lactato EV + Balance x 24-48 h	Falta de tránsito a las 48-72 h o dolor continuo	Laparotomía / Laparoscopía con lisis de bridas (adhesiolisis)
Hernia Inguinal/Crural Atascada	Intento prudente de reducción suave en < 4-6 h (taxis)	Dolor exquisito, cambios cutáneos eritematosos o peritonismo	Hernioplastia urgente con exploración y resección de asa necrosada
Vólvulo Sigmoides No Necrosado	Desvolvulación endoscópica (rectosigmoidoscopía) + sonda	Isquemia mucosa endoscópica, perforación o peritonitis	Sigmoidectomía electiva en misma hospitalización (o Hartmann)
Cáncer Colorrectal Oclusivo	Estabilización, corrección electrolítica y TAC urgente	Riesgo de perforación cecal si diámetro ciego > 10-12 cm	Operación de Hartmann o colectomía subtotal de urgencia

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **8–17, 49, 55** (págs. 14–16, 21–22) · solucionario págs. 30–31, 35–36.

Clase 11.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

11.5 Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)

★★★ PRIORIDAD ALTA
12 preguntas reales 2013–2025

4.01.2.003 Peritonitis — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Úlcera péptica · Abdomen agudo · Radiografía de tórax

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Peritonitis primaria (PBE)** = cirrótico, monomicrobiana, PMN **≥ 250/mm³** en líquido ascítico, manejo MÉDICO con Cefotaxima EV.
- **Peritonitis secundaria** = rotura de víscera hueca, polimicrobiana, neumoperitoneo, manejo QUIRÚRGICO de urgencia.
- El dolor "en puñalada" de inicio súbito + "vientre en tabla" + signo de Jobert (timpanismo hepático) es patognomónico de úlcera perforada.
- La radiografía de tórax de pie es el estudio inicial más rápido para confirmar neumoperitoneo (semiluna subdiafragmática).
- El tratamiento de la úlcera péptica perforada es la laparotomía/laparoscopía con lavado peritoneal profuso y sutura con parche de epiplón (Graham).



NEUMOPERITONEO
Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 65

ALGORITMO · PERITONITIS GENERALIZADA: PRIMARIA O SECUNDARIA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

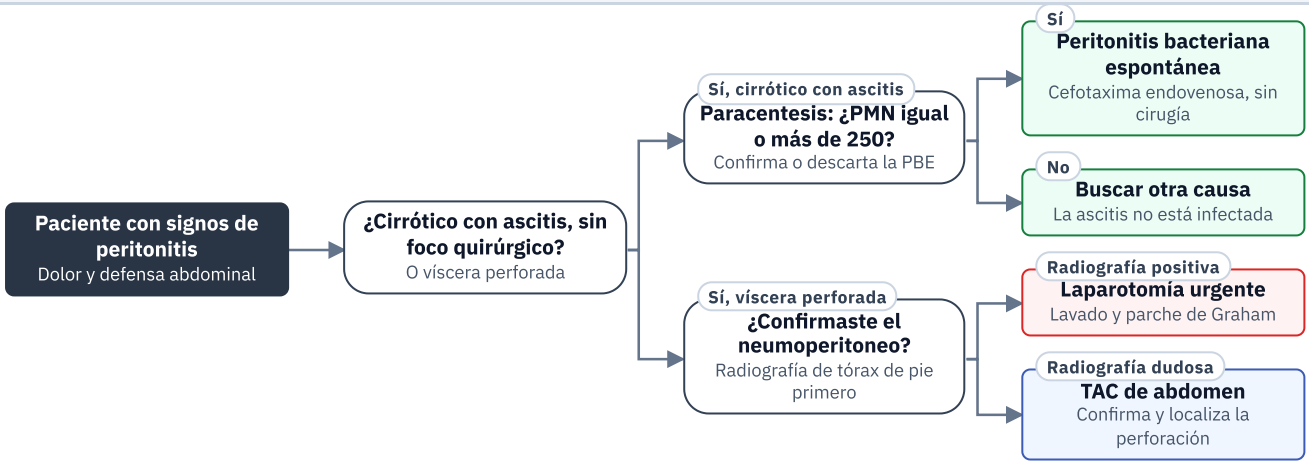


TABLA 11.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLAVE: PERITONITIS PRIMARIA VS SECUNDARIA VS TERCIARIA

CRITERIO DIFERENCIAL	PERITONITIS PRIMARIA (PBE)	PERITONITIS SECUNDARIA (QUIRÚRGICA)	PERITONITIS TERCIARIA (NOSOCOMIAL)
Población típica	Cirrótico con ascitis descompensada o nefrótico	Cualquier persona; úlcera, apendicitis, divertículo	Paciente crítico en UPC tras laparotomía previa
Mecanismo causal	Traslocación bacteriana monomicrobiana sin rotura	Perforación de víscera hueca o dehiscencia de sutura	Sobreinfección persistente en huésped inmunodeprimido
Microbiología	Monomicrobiana (E. coli, Klebsiella, Neumococo)	Polimicrobiana (Enterobacterias + B. fragilis)	Microorganismos multirresistentes (Candida, Enterococo)
Examen de elección	Paracentesis diagnóstica (PMN ≥ 250/mm³)	Radiografía de tórax / TAC (neumoperitoneo)	TAC con contraste + Cultivo de drenajes
Tratamiento	MÉDICO: Cefotaxima EV (¡Cirugía contraindicada!)	QUIRÚRGICO: Laparotomía urgente + Lavado	Re-laparotomía / Abdomen abierto + Antifúngicos

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Cirrótico, ascitis, PMN sobre 250	Cefotaxima endovenosa, sin cirugía	Operar de urgencia
Dolor en puñalada, abdomen en tabla	Radiografía de tórax de pie	Pedir endoscopía de entrada
Neumoperitoneo confirmado	Laparotomía urgente con parche de Graham	Tratar solo con antibióticos

REGLA DE ORO **Cirrótico, ascitis, PMN alto** — Cefotaxima, nunca cirugía

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, pregunta **50** (pág. 21) · solucionario pág. 36.

Clase 11.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PARED ABDOMINAL, HERNIAS & PROCTOLOGÍA

11.6 Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones

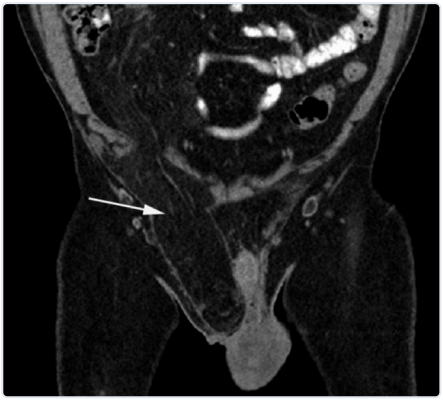
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

4.01.1.021 Hernias, eventraciones y eviscerationes — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

También: Hernia inguinal

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Hernia indirecta** = congénita, sale por anillo profundo, lateral a vasos epigástricos, desciende a escroto, más común en jóvenes.
- **Hernia directa** = adquirida, triángulo de Hesselbach, medial a vasos epigástricos, debilidad de fascia transversalis.
- **Hernia crural** = por debajo del ligamento inguinal y medial a vena femoral; máxima tasa de estrangulación (**30-40%**) en mujeres añosas.
- **Hernia estrangulada** = dolor severo + signos inflamatorios cutáneos + íleo; CONTRAINDICADA LA REDUCCIÓN MANUAL (TAXIS).
- **Hernia de Richter** = pinzamiento del borde antimesentérico con isquemia y necrosis sin obstrucción luminal completa.



HERNIA INGUINOESCROTAL
CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 393

ALGORITMO · HERNIAS DE PARED ABDOMINAL: UBICACIÓN Y URGENCIA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

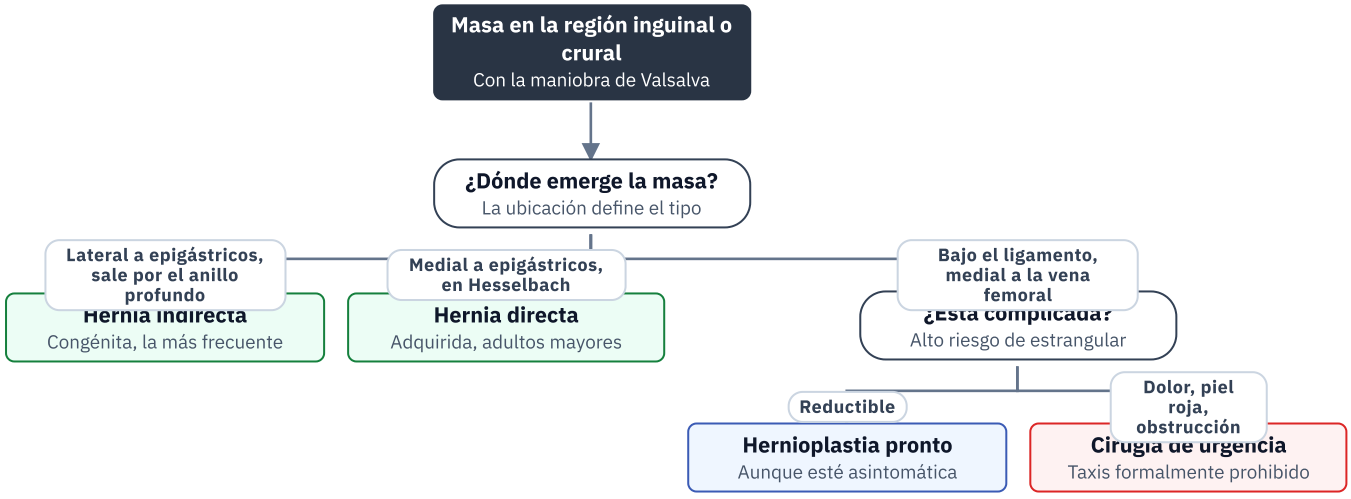


TABLA 11.6 · DIAGNÓSTICO ANATÓMICO Y DIFERENCIAL: HERNIA INGUINAL INDIRECTA VS DIRECTA VS CRURAL

TIPO DE HERNIA	MECANISMO PATOGÉNICO	RELACIÓN ANATÓMICA CARDINAL	RIESGO DE ESTRANGULACIÓN Y POBLACIÓN
Inguinal Indirecta (50%)	Congénita (persistencia conducto peritoneovaginal)	Emerge por anillo profundo, LATERAL a vasos epigástricos	Riesgo moderado; muy frecuente en hombres jóvenes y niños
Inguinal Directa (25%)	Adquirida (debilidad fascia transversalis en Hesselbach)	Protruye en triángulo de Hesselbach, MEDIAL a vasos epigástricos	Riesgo bajo de estrangulación (anillo ancho); adultos mayores
Crural / Femoral (5-10%)	Adquirida (debilidad de tabique crural)	POR DEBAJO del ligamento inguinal, medial a vena femoral	MÁXIMO RIESGO DE ESTRANGULACIÓN (35-40%); mujeres multíparas
Hernia Umbilical	Falla de cierre de anillo umbilical fibroso	Orificio umbilical en línea media	GES en < 15 años; riesgo de estrangulación alto si cuello estrecho

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

TIPO DE HERNIA	RELACIÓN ANATÓMICA	CONDUCTA CORRECTA
Estrangulada	Piel roja, caliente, dolor intenso	Cirugía urgente, sin taxis
Eventración (hernia incisional)	Defecto en cicatriz de laparotomía previa	Cirugía electiva con malla; la faja es paliativa
Niño menor de 15 años	Conducto peritoneovaginal permeable	Herniotomía simple, sin malla

REGLA DE ORO **Indirecta: lateral a epigástricos** — Directa: medial a epigástricos

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **18, 22–23, 89** (págs. 16–17, 28) · solucionario págs. 31–32, 41.

Clase 11.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PARED ABDOMINAL, HERNIAS & PROCTOLOGÍA

11.7 Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

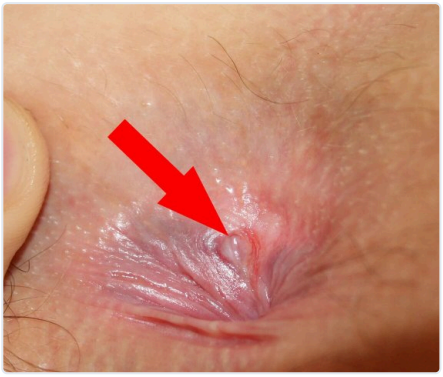
★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

4.01.1.016 Hemorroides - fisura anal — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Abscesos y fístulas ano rectales · Fisura anorectal · Cáncer anal · Prolapso rectal · Anoscopía

LO QUE TE PREGUNTAN

- Dolor lacerante ("cristales rotos") durante y tras la defecación = fisura anal (**90%** línea media posterior).
- **El tratamiento de 1ª línea de la fisura anal es médico**: fibra, agua, baños de asiento tibios y Diltiazem tópico al **2%**.
- Esfinterotomía lateral interna (ELI) es el estándar quirúrgico para la fisura anal crónica refractaria.
- **Hemorroides internas** = sangrado rojo rutilante indoloro en gotas; Grado I-II bandas elásticas, Grado III-IV hemorroidectomía.
- Trombosis hemorroidal externa < **72 horas** se trata con trombectomía/enucleación del coágulo bajo anestesia local.



FISURA ANAL
Wikimedia Commons «Anal fissure 1.jpg», Public domain, Bernardo Gui

ALGORITMO · PATOLOGÍA ORIFICIAL BENIGNA: EL SÍNTOMA GUÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

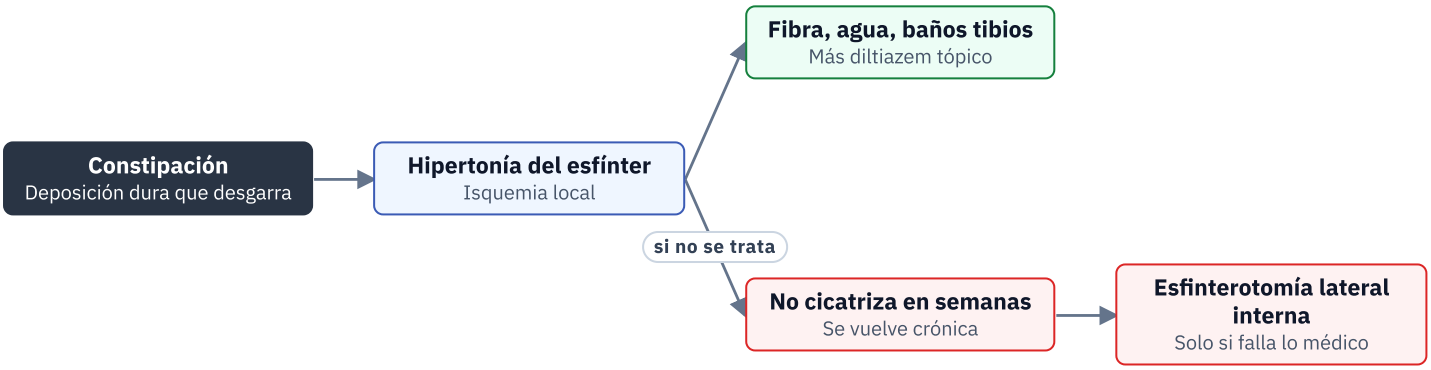


TABLA 11.7 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CARDINAL EN PATOLOGÍA ORIFICIAL BENIGNA

PATOLOGÍA PROCTOLÓGICA	SÍNTOMA PRINCIPAL GUÍA	HALLAZGO FÍSICO PATOGNOMÓNICO	CONDUCTA TERAPÉUTICA DE ELECCIÓN
Fisura Anal	Dolor lacerante exquisito defecatorio persistente	Desgarro lineal anodérmico en línea media posterior (90%)	Médico: Fibra, baños de asiento, Diltiazem tópico 2% (o ELI)
Hemorroides Internas	Rectorragia roja rutilante indolora post-defecación	Prolapso de paquetes mucosos vasculares con Valsalva	Grado I-II: Dieta/Bandas elásticas · Grado III-IV: Hemorroidectomía
Trombosis Hemorroidal	Dolor brusco severo continuo no defecatorio	Nódulo violáceo tenso, palpable, azulado en margen anal	< 72 h: Trombectomía bajo anestesia local · > 72 h: Conservador
Absceso Perianal	Dolor pulsátil continuo severo, tumefacción	Masa indurada eritematosa caliente perianal dolorosa	DRENAJE QUIRÚRGICO INMEDIATO (No esperar fluctuación)
Fístula Anorrectal	Supuración purulenta crónica intermitente indolora	Orificio cutáneo perianal permeable con cordón fibroso	Fistulotomía o colocación de sedal (seton) según trayecto

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CUADRO	SÍNTOMA GUÍA	CONDUCTA CORRECTA
Hemorroide interna	Sangrado indoloro	Grado I-II médico, III-IV cirugía
Lesión anal que no cura	Biopsia; quimiorradioterapia	Operar primero o llamarla hemorroide
Prolapso rectal	Pliegues concéntricos; cirugía	Confundirlo con hemorroide prolapsada

REGLA DE ORO **Dolor al defecar** — Fisura anal

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **24–31, 43, 51, 61** (págs. 17–18, 20–21, 23) · solucionario págs. 32–33, 35–37.

Clase 11.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PARED ABDOMINAL, HERNIAS & PROCTOLOGÍA

11.8 Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

4.01.1.018 **Enfermedades del seno pilonidal** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Tumores benignos de partes blandas · Tumores malignos de partes blandas · Abscesos, forúnculos, panadizos, flegmones · Drenaje de lesiones superficiales · Granuloma piogénico

LO QUE TE PREGUNTAN

- La enfermedad pilonidal se produce por invaginación de pelos en los folículos de la hendidura interglútea en jóvenes.
- En fase aguda (absceso pilonidal), la conducta es DRENAJE QUIRÚRGICO SIMPLE con curetaje de pelos (no resección amplia).
- La resección en bloque del seno pilonidal se programa de forma ELECTIVA tras resolver el proceso agudo infeccioso.
- La hidrosadenitis supurativa compromete glándulas apocrinas en axilas e ingles con fístulas y cicatrices cordonales crónicas.
- **Quiste epidérmico** = orificio o poro central punctiforme adherido a epidermis; extirpación completa de la cápsula para evitar recidiva.
- **Banderas rojas de Sarcoma de partes blandas**: tamaño > **5 cm**, localización profunda/subfascial, consistencia dura y crecimiento rápido.



ABSCESO PILONIDAL
Wikimedia Commons «Pilonidal abscess.jpg», CC BY-SA 4.0, Jonathanlund

ALGORITMO · PARTES BLANDAS: CUÁNDO DRENAR Y CUÁNDO ESTUDIAR ANTES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

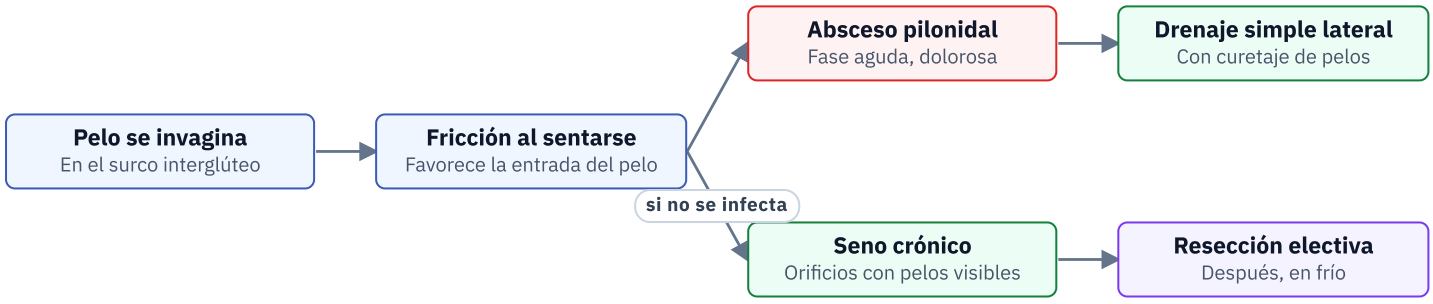


TABLA 11.8 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LIPOMA VS QUISTE EPIDÉRMICO VS SARCOMA DE PARTES BLANDAS

CARACTERÍSTICA	LIPOMA BENIGNO SUBCUTÁNEO	QUISTE EPIDÉRMICO (SEBÁCEO)	SARCOMA DE PARTES BLANDAS (MALIGNO)
Capa anatómica	Tejo celular subcutáneo superficial	Intradérmico adherido a epidermis	Profundo (subfascial o intramuscular)
Consistencia y bordes	Blando, lobulado, bordes netos móviles	Elástico, renitente, adherido a piel	Duro, pétreo, firme, mal delimitado o lobulado
Signo patognomónico	Signo del resbalamiento bajo los dedos	Poro / Punctum central visible en piel	Fijación estricta a planos profundos o hueso
Tamaño y evolución	Habitualmente < 5 cm, crecimiento lento	Varía 1 a 4 cm, puede sobreinfectarse	> 5 cm, crecimiento rápido e inexorable
Tratamiento definitivo	Enucleación quirúrgica con cápsula	Exéresis completa de la cápsula íntegra	Resonancia + Biopsia Tru-Cut + Cirugía oncológica

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Absceso pilonidal agudo	Drenaje simple lateralizado	Resección amplia en fase aguda
Seno pilonidal crónico	Resección electiva, en frío	Operar mientras está infectado
Quiste epidérmico infectado	Drenar primero, resecar después	Extirpar la cápsula en plena infección

REGLA DE ORO **Agudo: drenaje lateralizado** — Crónico: resección electiva

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **32–36, 52–53** (págs. 18–19, 21–22) · solucionario págs. 33–34, 36.

Clase 11.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PARED ABDOMINAL, HERNIAS & PROCTOLOGÍA

11.19 Patología Vascular Periférica: Aneurismas, Várices e Insuficiencia Venosa & Úlceras de las Piernas

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

Alta rentabilidad · várices simples con manejo conservador, úlcera venosa maleolar medial frente a la arterial y complicación del aneurisma poplíteo (trombosis y embolia, no rotura)

4.01.1.044 **Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Várices. Insuficiencia venosa crónica · Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)

LO QUE TE PREGUNTAN

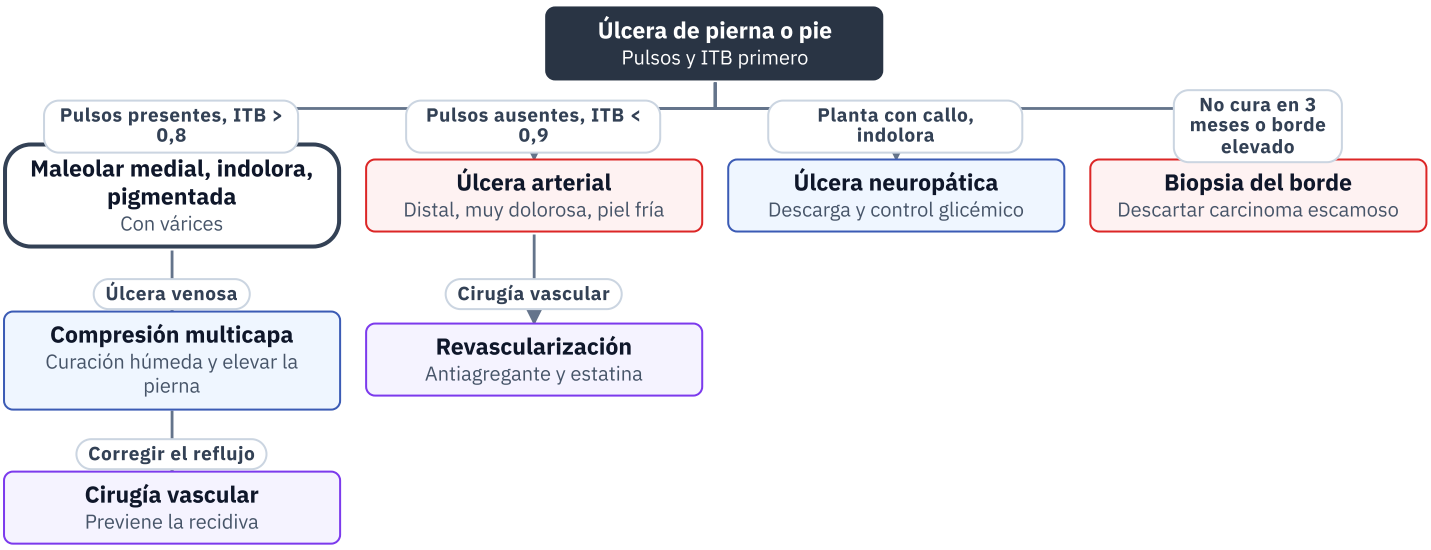
- El aneurisma poplíteo se complica con trombosis o embolia distal (isquemia aguda), no con rotura; es bilateral en la mitad de los casos y se asocia a aneurisma aórtico.
- **Aneurisma de aorta torácica**: control de la presión con betabloqueo y cirugía desde **5,5 cm**, crecimiento rápido o síntomas.
- **Varices simples sin complicaciones**: manejo inicial conservador con ejercicio, elevación, control del peso y medias de compresión.
- Tromboflebitis superficial de **5 cm** o más o cerca de la unión safenofemoral: anticoagulación por riesgo de trombosis profunda.
- La úlcera venosa es maleolar medial, poco dolorosa y con hiperpigmentación; la arterial es distal, muy dolorosa y con pulsos ausentes.
- **Medir el ITB y palpar pulsos antes de comprimir una úlcera**: la compresión está contraindicada si el ITB es menor de 0,8.
- Toda úlcera que no cura en **3 meses** o de bordes atípicos requiere biopsia para descartar carcinoma escamoso.



VÁRICES EXTENSAS
Fitzpatrick, Dermatology in General Medicine, p. 1719

ALGORITMO · ÚLCERA CRÓNICA DE LA PIERNA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **4, 6, 41–42, 58, 76** (págs. 13–14, 20, 22, 26) · solucionario págs. 29, 34–35, 37, 39.

Clase 11.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PARED ABDOMINAL, HERNIAS & PROCTOLOGÍA

11.19 Patología Vascular Periférica: Aneurismas, Várices e Insuficiencia Venosa & Úlceras de las Piernas

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 11.19 · ÚLCERAS DE LAS PIERNAS: CÓMO DISTINGUIRLAS

TIPO	UBICACIÓN Y ASPECTO	DOLOR Y PIEL	PULSOS / ITB	CONDUCTA
Venosa	Maleolar medial, bordes irregulares, fondo granulante con fibrina	Poco dolorosa · hiperpigmentación, eczema, lipodermatoesclerosis	Presentes · ITB > 0,8	Compresión multicapa, curación húmeda, elevar, tratar reflujo
Arterial	Dedos, talón, maléolo lateral · «en sacabocados»	Muy dolorosa · piel fría, pálida, sin vello	Ausentes · ITB < 0,9	NO comprimir · derivar a vascular
Neuropática (diabética)	Planta, puntos de presión, callo	Indolora · pérdida de sensibilidad	Variables	Descarga, curación, control glicémico, derivar
Hipertensiva (Martorell)	Cara posterolateral de la pierna, necrótica	Muy dolorosa · hipertensión, diabetes	Presentes	Control de la presión · injerto · derivar
Específica / neoplásica	Borde violáceo, elevado o atípica	Variable	Variables	Biopsia del borde · tratar la causa

TRAMPAS EUNACOM

LOCALIZACIÓN	COMPLICACIÓN TÍPICA	CUÁNDO SE OPERA	CLAVE
Aorta torácica	Disección o rotura	≥ 5,5 cm, crece > 0,5 cm/año o síntomas	Betabloqueo y control de la presión
Poplíteo	Trombosis y embolia distal	≥ 2 cm, trombo o síntomas	Bilateral en la mitad; buscar aneurisma aórtico
Femoral	Trombosis y embolia distal	Sintomático o ≥ 2,5 cm	Seudoaneurisma: masa pulsátil con soplo

REGLA DE ORO **Poplíteo: se obstruye, no se rompe** — Bilateral y asociado a aneurisma aórtico

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La patología vascular periférica ocupa un lugar central en la consulta quirúrgica ambulatoria. Los aneurismas de aorta torácica, femoral y poplítea son dilataciones arteriales que el médico general debe sospechar (masa pulsátil, hallazgo radiológico) y derivar: su peligro es la rotura en el caso de la aorta y la trombosis o embolia distal en el caso del aneurisma poplíteo. La insuficiencia venosa crónica y las várices son un problema de enorme frecuencia, sobre todo en mujeres, que se maneja de manera conservadora y se complica con tromboflebitis, eczema y úlcera. La úlcera de pierna obliga a distinguir su origen venoso, arterial, neuropático o específico, porque el tratamiento de cada una es distinto y la compresión es peligrosa en la isquemia.

TABLA 11.19.B · ANEURISMAS PERIFÉRICOS: CONDUCTA SEGÚN LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN	COMPLICACIÓN TÍPICA	CUÁNDO SE OPERA	CLAVE DE EXAMEN
Aorta torácica	Disección o rotura	≥ 5,5 cm, crecimiento > 0,5 cm/año o sintomático	Betabloqueo, control de la PA, derivar
Poplíteo	Trombosis y embolia distal (isquemia aguda)	≥ 2 cm, trombo mural o sintomático	Masa pulsátil poplítea · bilateral en la mitad · buscar aneurisma aórtico
Femoral	Trombosis y embolia distal	Sintomático o ≥ 2,5 cm	Seudoaneurisma tras cateterismo: masa pulsátil con soplo

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **4, 6, 41–42, 58, 76** (págs. 13–14, 20, 22, 26) · solucionario págs. 29, 34–35, 37, 39.

Clase 11.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PARED ABDOMINAL, HERNIAS & PROCTOLOGÍA

11.20 Obesidad Mórbida y Cirugía Bariátrica: Indicaciones, Técnicas y Complicaciones

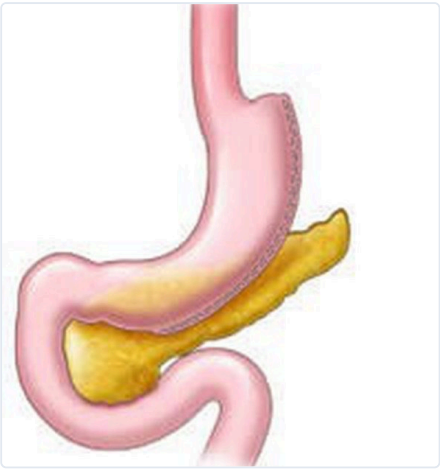
PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

Alta rentabilidad · síndrome de dumping tras bypass gástrico, indicaciones de cirugía bariátrica y déficits nutricionales del postoperatorio

4.01.1.060 **Obesidad mórbida** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Obesidad mórbida**: IMC de 40 o más, o de 35 o más con comorbilidades.
- **Indicación de cirugía bariátrica**: IMC adecuado, fracaso de manejo médico supervisado de **6 meses** o más y paciente motivado sin contraindicaciones.
- La manga gástrica es la técnica más usada; el bypass en Y de Roux logra más pérdida de peso y remisión de diabetes y reflujo.
- Taquicardia persistente en el postoperatorio inmediato es el primer signo de fuga anastomótica.
- **Dumping tras bypass**: síntomas vasomotores y diarrea minutos después de comer; se maneja con dieta fraccionada sin azúcares simples.
- Colelitiasis, hernia interna y déficits de hierro, B12, calcio y vitamina D son complicaciones tardías; los suplementos son de por vida.



MANGA GÁSTRICA
Harrison 21.ª ed., Fig. 402-3

ALGORITMO · PACIENTE CON CIRUGÍA BARIÁTRICA QUE CONSULTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

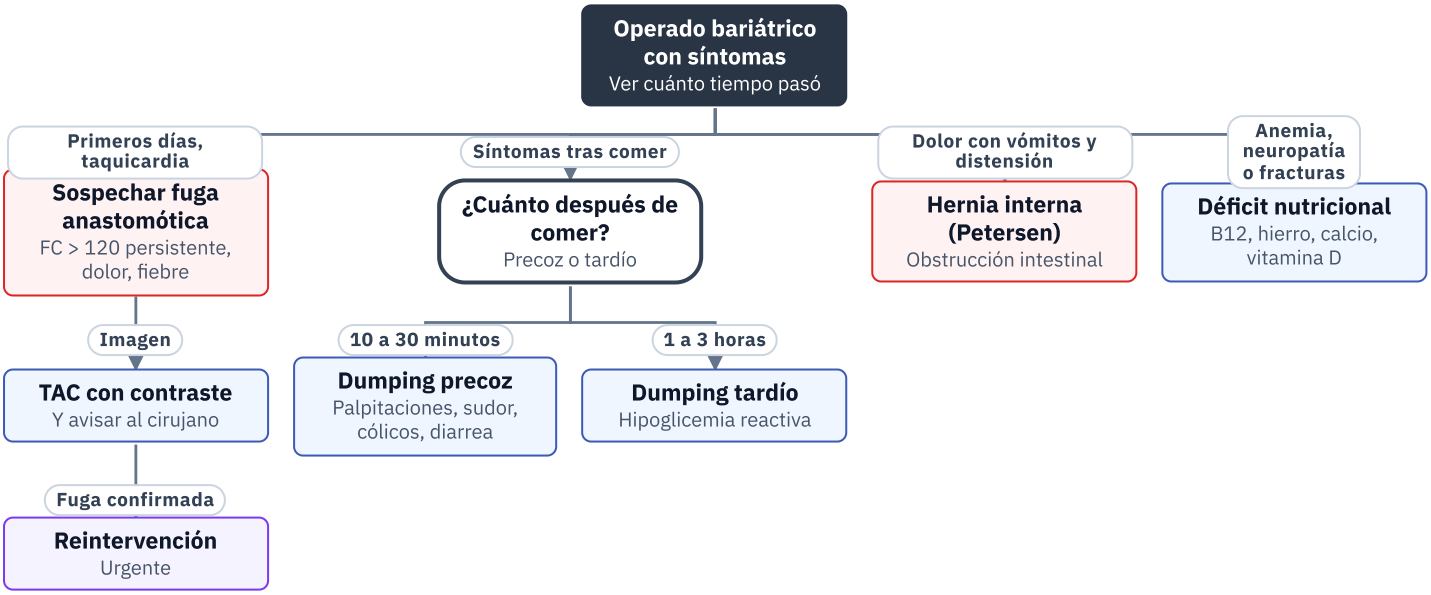


TABLA 11.20 · TÉCNICAS DE CIRUGÍA BARIÁTRICA

TÉCNICA	MECANISMO	VENTAJA	COMPLICACIONES PROPIAS
Manga gástrica (gastrectomía vertical)	Restrictiva · se reseca ~80% del estómago	La más realizada · técnicamente simple	Reflujo, fuga de la línea de grapas, estenosis
Bypass gástrico en Y de Roux	Mixta · reservorio gástrico pequeño y exclusión del duodeno	Mayor pérdida de peso · remisión de DM2 y reflujo	Dumping, hernia interna, úlcera marginal, déficits (hierro, B12, calcio)
Derivación biliopancreática	Malabsortiva predominante	Gran pérdida de peso	Desnutrición proteica, diarrea, déficits vitamínicos graves
Banda gástrica ajustable	Restrictiva	Reversible	Deslizamiento, erosión · hoy en desuso

REGLA DE ORO **IMC ≥ 40, o ≥ 35 con comorbilidad** — Y fracaso de 6 meses de manejo médico

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, pregunta **45** (pág. 21) · solucionario pág. 35.

Clase 11.20 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

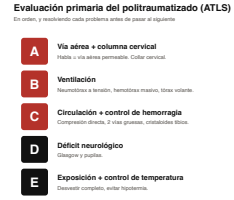
★★★ PRIORIDAD ALTA
5 preguntas reales 2013–2025

4.01.2.027 Trauma — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Evaluación primaria en trauma · Evaluación secundaria en trauma · Manejo de vía aérea y columna cervical en trauma · Traumatismo raquimedular · Shock · Conceptos de manejo en situación de catástrofe (triage, extricación, inmovilización y transporte) · Radiografía de columna cervical · Cricoidostomía · Denudación venosa · Intubación traqueal · Traslado del traumatizado · Politraumatismos · Trauma raquimedular · Triage · Traqueostomía y cricoidostomía

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Prioridad ATLS absoluta**: Tratar primero la lesión que mata primero; evaluación y reanimación simultáneas.
- A: Control cervical estricto en línea bimanual; retirar collar solo para intubación manteniendo alineación manual.
- **Criterio de vía aérea definitiva**: Escala de Coma de Glasgow **≤ 8 puntos**, apnea, trauma inhalatorio o volet torácico grave.
- B: Descartar y tratar inmediatamente el neumotórax a tensión (descompresión clínica sin radiografía previa).
- C: Control de hemorragias externas exanguinantes con presión o torniquete; reposición 1:1:1 y Ácido Tranexámico < **3 horas**.



ABCDE
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · ATLS: EL ORDEN QUE DECIDE QUÉ SE TRATA PRIMERO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

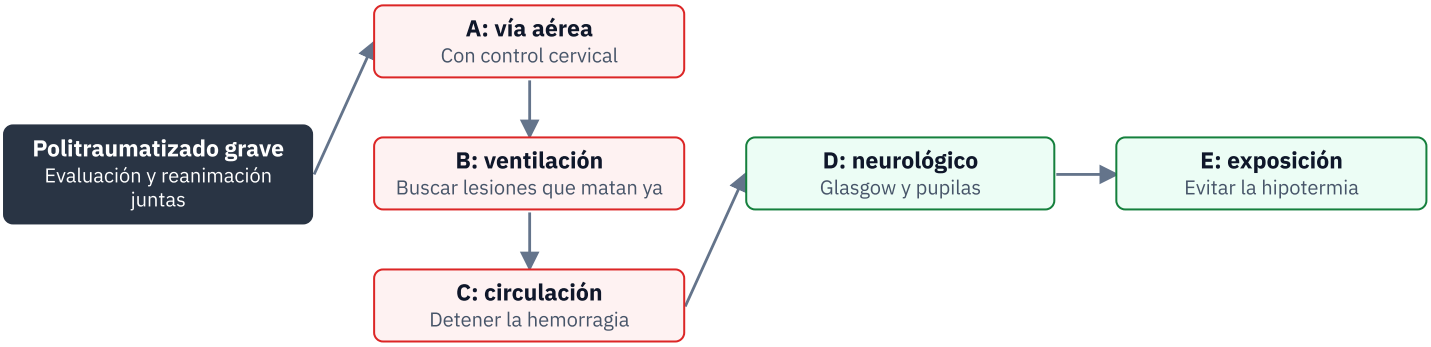


TABLA 11.9 · PROTOCOLO ATLS — EVALUACIÓN PRIMARIA (A-B-C-D-E), ACCIONES Y ERRORES FATALES

ETAPA ATLS	PRIORIDAD Y HALLAZGO EVALUADO	ACCIÓN TERAPÉUTICA INMEDIATA	ERROR FATAL FRECUENTE
A (Airway)	Permeabilidad de vía aérea y estabilidad cervical	Alineación bimanual cervical en línea + IOT si GCS ≤ 8	Hiperextender el cuello o demorar cricotiroidotomía
B (Breathing)	Ventilación y lesiones torácicas de riesgo vital	Oxígeno alto flujo + Descompresión con aguja/tubo	Esperar radiografía en neumotórax a tensión
C (Circulation)	Control de hemorragias externas y shock hemorrágico	Presión directa, torniquete, protocolo 1:1:1 + Ácido tranexámico	Sobrecargar con cristaloides (> 1 L) induciendo coagulopatía
D (Disability)	Nivel de conciencia y reactividad pupilar	Escala Glasgow + Evaluar asimetría o midriasis pupilar	Atribuir compromiso de conciencia solo a intoxicación
E (Exposure)	Inspección de toda la superficie corporal y dorso	Giro en bloque (log-roll) + Mantas térmicas y sueros tibios	Dejar al paciente desnudo provocando hipotermia refractaria

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Glasgow de 8 o menos	Intubación con control cervical	Hiperextender el cuello o esperar
Sospecha de neumotórax a tensión	Descompresión inmediata	Pedir radiografía antes de actuar
Hemorragia externa mayor	Presión, torniquete y ácido tranexámico antes de tres horas	Pasar más de un litro de suero fisiológico

REGLA DE ORO — **Primero lo que mata primero** — A, B, C, D, E, siempre en ese orden

PRACTICA — **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **54, 72, 80, 82, 90** (págs. 22, 25–28) · solucionario págs. 36, 38–41.

Clase 11.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

11.10 Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante

★★★ **PRIORIDAD ALTA**
9 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad histórica en EUNACOM · 6 preguntas directas de exámenes oficiales sobre drenajes y lesiones torácicas

4.01.2.016 **Traumatismo torácico grave** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Neumotórax hipertensivo · Taponamiento pericárdico · Drenaje pleural · Traumatismo torácico simple

LO QUE TE PREGUNTAN

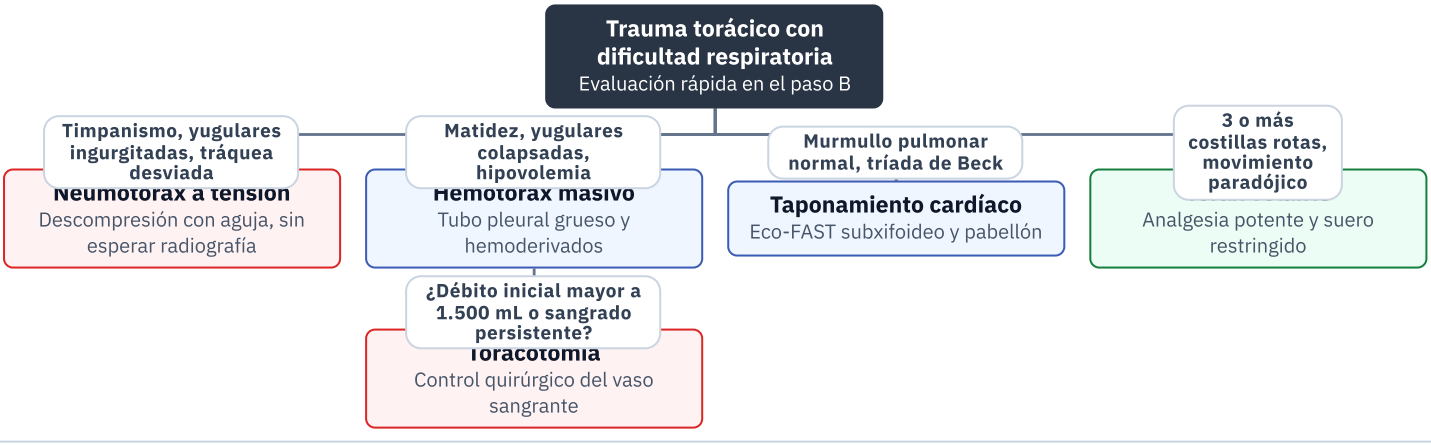
- **Neumotórax a tensión** = hipotensión + timpanismo + abolición de MP + ingurgitación yugular + desviación traqueal.
- El diagnóstico del neumotórax a tensión es CLÍNICO; PROHIBIDO esperar radiografía; descompresión inmediata con aguja en 5° EIC LAA.
- **Hemotórax masivo** = matidez + abolición de MP + shock hipovolémico con yugulares colapsadas (planas).
- **Indicación de toracotomía de urgencia en hemotórax**: débito inicial **≥ 1.500 mL** o sangrado persistente > **200 mL**/h x **2-4 horas**.
- **Tórax volante (flail chest)** = **≥ 3 costillas** rotas en **≥ 2 segmentos**; la causa de la hipoxemia es la CONTUSIÓN PULMONAR subyacente.
- **En volet y contusión pulmonar**: analgesia potente (bloqueo epidural/regional), oxígeno y RESTRICCIÓN prudente de fluidos.
- Tríada de Beck (hipotensión + ruidos cardíacos apagados + ingurgitación yugular) + pulso paradójico = taponamiento cardíaco (Eco-FAST).



NEUMOTÓRAX A TENSIÓN
Manual CTO Cirugía 14.ª ed., p. 71

ALGORITMO · TRAUMA TORÁCICO MAYOR: QUÉ LESIÓN ES, SEGÚN PERCUSIÓN Y YUGULARES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **66, 75** (págs. 24–25) · solucionario págs. 38–39.

Clase 11.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

11.10 Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 11.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: NEUMOTÓRAX A TENSIÓN VS HEMOTÓRAX MASIVO VS TAPONAMIENTO

SIGNO / HALLAZGO CLÍNICO	NEUMOTÓRAX A TENSIÓN	HEMOTÓRAX MASIVO	TAPONAMIENTO CARDÍACO
Presión arterial y pulso	Hipotensión severa; taquicardia	Hipotensión severa (shock hipovolémico)	Hipotensión con pulso paradójico
Murmullo vesicular	Abolido o muy disminuido ipsilateral	Abolido ipsilateralmente	Murmullo vesicular NORMAL bilateral
Percusión torácica	TIMPANISMO hiperresonante marcado	MATIDEZ franca en hemitórax afecto	Sonoridad pulmonar conservada
Venas del cuello	INGURGITACIÓN yugular prominente	PLANAS / COLAPSADAS (hipovolemia)	INGURGITACIÓN yugular prominente
Posición traqueal	Desviación CONTRALATERAL de tráquea	Normal o levemente contralateral	Tráquea rigurosamente CENTRADA
Tratamiento de elección	Punción descompresiva 14G -> Tubo pleural	Tubo pleural grueso (28-32 Fr) + Sangre	Eco-FAST -> Ventana pericárdica / Quirúrgico

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

SIGNO CLAVE	NEUMOTÓRAX A TENSIÓN	HEMOTÓRAX MASIVO	TAPONAMIENTO CARDÍACO
Murmullo pulmonar	Abolido de un lado	Abolido de un lado	Normal, sin cambios
Ante la duda diagnóstica	Descomprimir sin esperar radiografía	Tubo pleural grueso	Eco-FAST subxifoideo

REGLA DE ORO **Timpanismo con yugulares altas** — Neumotórax a tensión: descomprime ya

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El trauma torácico es responsable de hasta un 25% de las muertes en pacientes politraumatizados. Más del 85% de las lesiones torácicas pueden resolverse de forma definitiva mediante procedimientos sencillos como el drenaje pleural o analgesia adecuada, requiriendo toracotomía quirúrgica formal menos del 10-15%. La causa más frecuente de muerte prevenible en el box de reanimación es el retraso en la descompresión de un neumotórax a tensión por esperar una radiografía de confirmación, lo cual constituye una infracción médica inexcusable.

TABLA 11.10.B · TÉCNICA DE PLEUROSTOMÍA, SELECCIÓN DE TUBOS Y CUIDADO DE DRENAJES PLEURALES

PASO / PROCEDIMIENTO	DETALLE TÉCNICO ESTANDARIZADO	MATERIAL / CALIBRE RECOMENDADO	ERRORES CRÍTICOS A EVITAR
Sitio de inserción	5° Espacio Intercostal, entre línea axilar anterior y media	Triángulo de seguridad de la pared torácica lateral	Colocarlo muy bajo (> 6° EIC) perforando diafragma, bazo o hígado
Paso de la costilla	Incisión y disección POR EL BORDE SUPERIOR de la costilla inferior	Protege el paquete vasculonervioso intercostal subcostal	Incisión pegada al borde inferior costal seccionando arteria intercostal
Calibre de tubo	Neumotórax simple: 20-24 Fr · Hemotórax masivo: 28-32 Fr	Tubo torácico con mandril retirado antes de penetrar pleura	Usar tubos finos en hemotórax que se ocluyen precozmente por coágulos
Conexión y succión	Sistema cerrado con sello de agua a -20 cmH2O de aspiración	Frasco de drenaje bajo el nivel del tórax del paciente	Elevar el frasco de drenaje sobre la camilla reingresando líquido a la pleura

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **66, 75** (págs. 24–25) · solucionario págs. 38–39.

Clase 11.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

11.11 Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia

★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
3 preguntas reales 2013–2025

Muy alta frecuencia en el EUNACOM · Pregunta angular de decisión entre pabellón inmediato vs TAC abdominal

`4.01.2.010` **Trauma abdominal abierto y cerrado** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Ecografía: distinguir vesícula y líquido intraabdominal · Trauma urológico

LO QUE TE PREGUNTAN

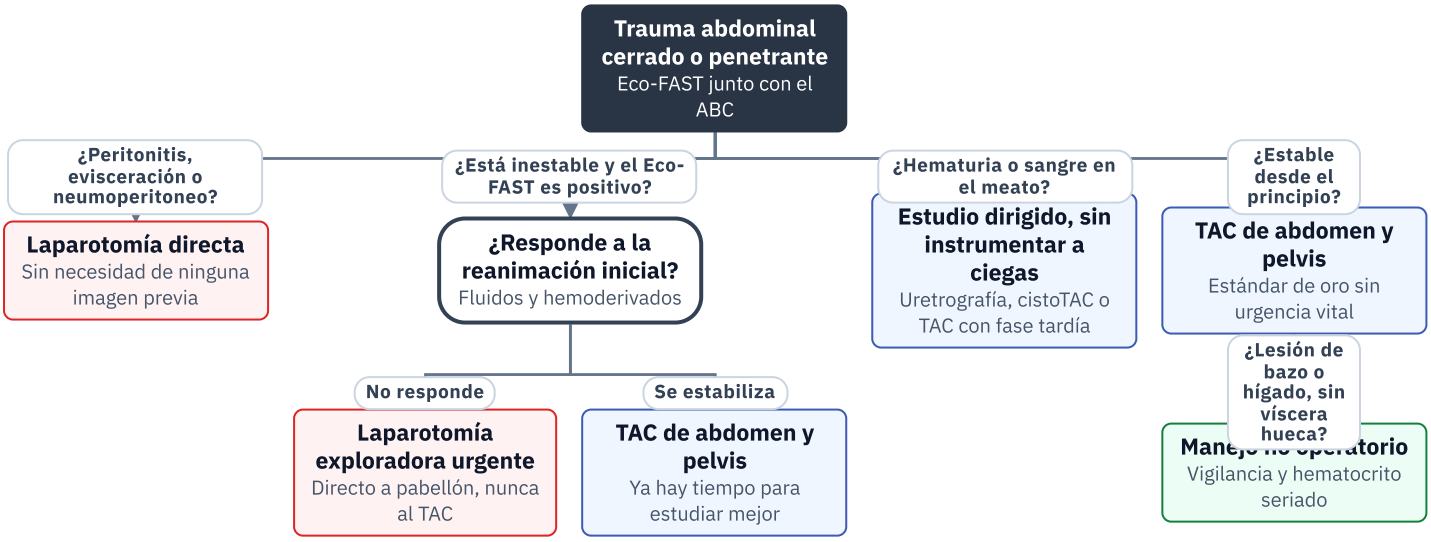
- En trauma abdominal cerrado, los órganos más frecuentemente lesionados son el bazo (1°) y el hígado (2°).
- En trauma penetrante por arma blanca el órgano más lesionado es el hígado; por arma de fuego es el intestino delgado.
- **El Eco-FAST evalúa 4 ventanas buscando LÍQUIDO LIBRE anormal**: Morrison (hepatorrenal), esplenorrenal, pélvico y pericárdico.
- **Paciente INESTABLE (PAS < 90) + Eco-FAST (+)** = LAPAROTOMÍA EXPLORADORA URGENTE INMEDIATA (prohibido TAC).
- **Paciente ESTABLE** = TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso (estándar de oro para MNO y gradación AAST).
- **Manejo No Operatorio (MNO) de bazo/hígado**: paciente estable, sin peritonitis ni lesión de víscera hueca; angioembolización si hay blush.
- Todo paciente sometido a esplenectomía total debe recibir vacunación contra bacterias capsuladas (Neumococo, Meningococo, Hib).



SIGNO DEL CINTURÓN
Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 124

ALGORITMO · TRAUMA ABDOMINAL: LA ESTABILIDAD DECIDE EL CAMINO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **68, 83** (págs. 24, 27) · solucionario págs. 38, 40.

Clase 11.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

11.11 Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 11.11 · GRADACIÓN AAST Y CRITERIOS DE MANEJO EN TRAUMA ESPLÉNICO Y HEPÁTICO

GRADO AAST	LESIÓN ESPLÉNICA / HEPÁTICA TÍPICA	ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO ESTÁNDAR	CRITERIOS DE CONVERSIÓN QUIRÚRGICA
Grado I	Hematoma subcapsular < 10% superficie; laceración capsular < 1 cm profundidad	Manejo No Operatorio (MNO): Reposo en cama x 48 h + Hematocrito seriado	Deterioro hemodinámico o caída inexplicable > 3-4 puntos de hematocrito
Grado II	Hematoma subcapsular 10-50%; laceración parenquimatosa 1-3 cm	MNO en sala de agudos / UPC; monitorización no invasiva estricta	Aparición de dolor abdominal difuso progresivo o peritonismo franco
Grado III	Hematoma subcapsular > 50% o roto; laceración > 3 cm profundidad	MNO en UPC; AngioTAC urgente; embolización si hay extravasación (blush)	Requerimiento transfusional > 2 unidades de GR en 24 horas
Grado IV	Laceración que compromete vasos segmentarios o hiliares con desvascularización > 25%	Angioembolización si está estable; Cirugía urgente si hay shock	Inestabilidad hemodinámica persistente refractaria a resucitación
Grado V	Estallido esplénico o hepático completo; desvascularización total del órgano	Laparotomía urgente: Esplenectomía total (bazo) / Packing hepático	Pabellón directo inmediato por shock hemorrágico exanguinante

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Inestable con Eco-FAST positivo	Laparotomía urgente, directo a pabellón	Enviar al paciente al TAC
Herida penetrante en hipocondrio izquierdo, estable	Laparoscopía diagnóstica del diafragma	Dar de alta sin más estudio
Sangre en el meato tras fractura pélvica	Uretrografía retrógrada y cistostomía si hay retención	Pasar una sonda Foley a ciegas

REGLA DE ORO **Inestable + Eco-FAST positivo** — Pabellón directo, nunca el TAC

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El abdomen es una cavidad oculta capaz de albergar litros de sangre sin cambios físicos externos llamativos en las fases iniciales. En el trauma abdominal cerrado, los órganos lesionados con mayor frecuencia son el bazo (40-55%) y el hígado (35-45%). En el trauma penetrante por arma blanca, el hígado y el intestino delgado encabezan la frecuencia, mientras que en las heridas por arma de fuego el intestino delgado y el colon son los más vulnerables. La regla de oro en el EUNACOM es la bifurcación hemodinámica: paciente inestable con líquido libre en Eco-FAST va directamente a pabellón para laparotomía; paciente estable se estudia con TAC con contraste.

TABLA 11.11.B · PROTOCOLO DE VIGILANCIA DEL MANEJO NO OPERATORIO (MNO) Y CUIDADO DE ESPLENECTOMÍA

ASPECTO CLÍNICO	PROTOCOLO ESTANDARIZADO EN UPC / SALA	PARÁMETROS DE CONTROL Y MONITOREO	ACCIONES PREVENTIVAS CRÍTICAS
Monitoreo en MNO	Reposo absoluto en cama por 48 a 72 horas; régimen cero inicial	Hematocrito y hemoglobina cada 6-8 horas las primeras 24 h; signos vitales continuos	Ecografía o TAC de control solo si hay caída de hematocrito o dolor
Profilaxis Trombosis	Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina 40 mg SC/día)	Iniciar a las 24-48 horas si el hematocrito se mantiene estable	La tromboprofilaxis precoz es segura y previene tromboembolismo pulmonar
Vacunación Post-Esplenectomía	Profilaxis contra bacterias encapsuladas: Neumococo, Meningococo y H. influenzae tipo b	Administrar a los 14 días postoperatorios (o antes del alta)	Previene la sepsis fulminante por asplenia (OPSI) con mortalidad > 50%
Reincorporación física	Evitar deportes de contacto y levantamiento de peso durante 2 a 3 meses	Control clínico y ecográfico a las 6-8 semanas post-alta	Riesgo de rotura esplénica retardada (hematoma subcapsular tardío)

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **68, 83** (págs. 24, 27) · solucionario págs. 38, 40.

Clase 11.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

1.10.2.019 Traumatismo encéfalo craneano leve — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Traumatismo encefalocraneano grave · TAC de encefalo y columna · Hipertensión endocraneana · Radiografía de cráneo · Intubación nasogástrica · Traumatismo encéfalo- craneano · Compromiso de conciencia · Otorragia

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Clasificación de severidad según Escala de Glasgow**: Leve (13-15), Moderado (9-12), Grave (**≤ 8 puntos**).
- TEC grave (Glasgow **≤ 8**) exige INTUBACIÓN OROTRAQUEAL INMEDIATA y TAC de encéfalo sin contraste urgente.
- Signos de fractura de base de cráneo (ojos de mapache, signo de Battle, otorraquia, hemotímpano) OBLIGAN a TAC en TEC leve.
- **Hematoma epidural** = rotura de arteria meníngea media por fractura temporal, intervalo lúcido, TAC en lente biconvexa que NO cruza suturas.
- **Hematoma subdural agudo** = rotura de venas puente en ancianos/desaceleración, TAC en semiluna cóncava que SÍ cruza suturas.



OJOS DE MAPACHE
Wikimedia Commons «Bilateral periorbital ecchymosis (raccoon eyes).jpg», Public domain, Marion County Sheriff's Office

ALGORITMO · TEC: DEL GLASGOW AL HEMATOMA QUE CORRESPONDE

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

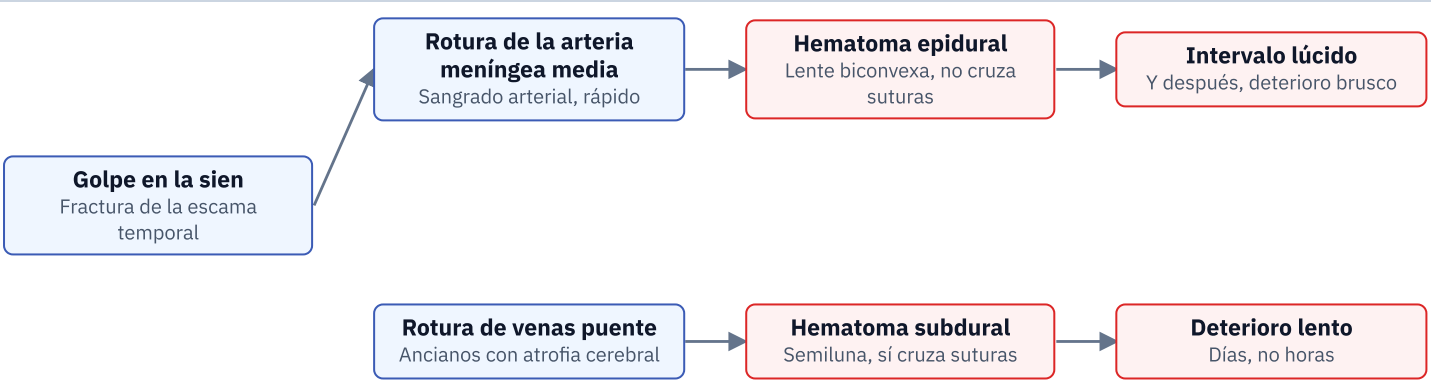


TABLA 11.12 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL TOMOGRÁFICO Y CLÍNICO: HEMATOMA EPIDURAL VS SUBDURAL VS HSA

CARACTERÍSTICA DIFERENCIAL	HEMATOMA EPIDURAL	HEMATOMA SUBDURAL AGUDO	HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMÁTICA
Vaso lesionado	Arteria Meníngea Media (85%) asociada a fractura temporal	Venas puente corticales parasagitales	Laceración de pequeños vasos piales o corticales
Espacio anatómico	Epidural (entre hueso craneal y duramadre)	Subdural (entre duramadre y aracnoides)	Subaracnoideo (en cisternas de la base y surcos)
Patrón tomográfico	Imagen hiperdensa en LENTE BICONVEXA; NO cruza suturas	Imagen hiperdensa en SEMILUNA CÓNCAVA; SÍ cruza suturas	Hiperdensidad lineal en surcos cerebrales y cisternas
Evolución clínica clásica	Intervalo lúcido -> deterioro brusco con midriasis	Deterioro neurológico progresivo e insidioso en ancianos	Cefalea occipital explosiva, fotofobia, meningismo
Tratamiento definitivo	Craneotomía y evacuación quirúrgica inmediata de urgencia	Craneotomía descompresiva si espesor > 10 mm o shift > 5 mm	Manejo médico en UPC, analgesia y neuroprotección

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Glasgow 15, mayor de 65 años o anticoagulado	TAC de cerebro de urgencia	Dar de alta por estar bien al examen
Intervalo lúcido y luego coma con midriasis	Craneotomía urgente por hematoma epidural	Atribuirlo a una embriaguez o sedación
Anciano con deterioro progresivo en días	Sospechar hematoma subdural	Buscar solo una causa metabólica o infecciosa

REGLA DE ORO **Fractura de base, 65 años, anticoagulado** — O vómitos repetidos y mecanismo de alta energía

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, pregunta **69** (pág. 24) · solucionario pág. 38.

Clase 11.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

11.13 Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

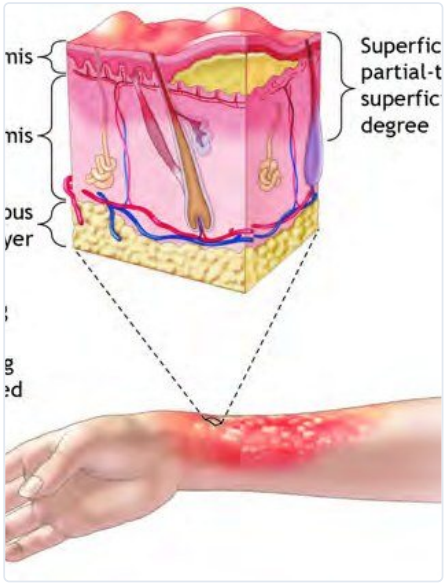
Muy alta rentabilidad en EUNACOM · Fórmulas de reanimación hidroelectrolítica y criterios de gravedad MINSAL

4.01.2.026 Quemaduras — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Curación básica de quemaduras · Secuelas de quemaduras · Conceptos generales sobre injertos y colgajos · Quemaduras · Quemadura solar

LO QUE TE PREGUNTAN

- Las quemaduras de 1° grado (eritema sin flictenas) NO se contabilizan para el cálculo de la SCQ ni en Parkland.
- **Segundo grado superficial** = flictenas rosadas húmedas muy dolorosas; tercer grado = escara acartonada seca insensible.
- **Criterio Gran Quemado (GES N° 56)**: Garcés > 70 pts, > **20%** SCQ en adultos (> **10%** en niños/ancianos) o zonas especiales.
- **Fórmula de Parkland**: **4 mL** x kg x % SCQ (2° y 3° grado) de Ringer Lactato en **24 horas**.
- El **50%** de Parkland se administra en las primeras **8 horas** CONTADAS DESDE EL MOMENTO DEL ACCIDENTE (no del ingreso).
- **Meta de diuresis horaria**: **0.5 a 1.0 mL/kg**/h en adultos y **1.0 a 1.5 mL/kg**/h en niños.
- Quemaduras circulares de 3° grado en extremidades o tórax requieren ESCAROTOMÍA DESCOMPRESIVA de urgencia inmediata.



ESPESOR PARCIAL SUPERFICIAL
ATLS 10.ª ed., Fig. 9-5

ALGORITMO · GRAN QUEMADO: LA SUPERFICIE DECIDE LA REPOSICIÓN Y LA DERIVACIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, pregunta **84** (pág. 27) · solucionario pág. 40.

Clase 11.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

11.13 Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 11.13 · REGLA DE LOS 9 DE WALLACE Y CÁLCULO DE SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA EN ADULTOS

SEGMENTO CORPORAL ANATÓMICO	% SCQ ADULTO (WALLACE)	CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS	REGLA DE LA PALMA
Cabeza y cuello	9% (4.5% anterior, 4.5% posterior)	Zona especial estética; alta sospecha de vía aérea	Palma del paciente con dedos juntos = 1% SCQ
Tronco anterior (tórax + abdomen)	18%	Evaluar restricción respiratoria si es circular	No incluir eritema de 1° grado en la suma
Tronco posterior (espalda + glúteos)	18%	Requiere log-roll en bloque para inspección completa	Usar Ringer Lactato tibio en reanimación
Cada extremidad superior (brazo + antebrazo + mano)	9% cada una (Total: 18%)	Manos son zona especial funcional (criterio GES)	Monitorear pulsos distales en quemaduras circulares
Cada extremidad inferior (muslo + pierna + pie)	18% cada una (Total: 36%)	Pies son zona especial funcional de apoyo	Riesgo de síndrome compartimental en piernas
Perineo y genitales externos	1%	Zona especial; alto riesgo de infección y estenosis	Colocar sonda Foley precoz antes de edema masivo

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Calcular la superficie quemada	Sumar solo segundo y tercer grado	Incluir el eritema de primer grado
Contar las ocho horas de Parkland	Desde la hora del accidente	Desde que el paciente llega al hospital
Rescatado de incendio, satura noventa y ocho por ciento	Sospechar monóxido igual, pedir carboxihemoglobina	Confiar en la oximetría de pulso

REGLA DE ORO **Wallace para la extensión** — El primer grado nunca se suma

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Las quemaduras graves desencadenan una respuesta inflamatoria sistémica masiva (SIRS) caracterizada por pérdida catastrófica de la permeabilidad capilar endotelial con fuga masiva de plasma, proteínas y electrolitos hacia el espacio intersticial ("shock por quemadura"). La mortalidad del gran quemado se define en las primeras 24 a 48 horas mediante una adecuada reanimación hidroelectrolítica con Ringer Lactato guiada por la diuresis horaria. En Chile, el Gran Quemado está protegido por la Garantía Explícita en Salud (GES N° 56), exigiendo derivación prioritaria antes de 24 horas a centros terciarios.

TABLA 11.13.B · RESUMEN DE FÓRMULAS DE PARKLAND, METAS DE DIURESIS Y CUIDADOS LOCALES

PARÁMETRO	FÓRMULA / RECOMENDACIÓN	META / VALOR NUMÉRICO	ERROR FATAL FRECUENTE
Volumen total en 24 h	4 mL x Peso (kg) x % SCQ (2° y 3° grado)	Ringer Lactato isotónico tibio	Calcular sobre quemaduras de 1° grado sobrestimando volumen
Distribución horaria	50% en primeras 8 horas, 50% en siguientes 16 h	Contadas desde la HORA DEL ACCIDENTE	Contar las 8 h desde el ingreso al hospital subreanimando
Meta diuresis (Adultos)	Sonda Foley con urómetro horario estricto	0.5 a 1.0 mL/kg/hora (30-50 mL/h)	Aumentar fluidos sin evaluar diuresis causando síndrome compartimental
Meta diuresis (Niños)	Sonda vesical pediátrica con urómetro	1.0 a 1.5 mL/kg/hora	No aportar mantención de dextrosa en niños provocando hipoglicemia
Tratamiento de escara	Escarotomía en quemaduras circulares de 3° grado	Incisiones axiales medial y lateral profundas	Demorar la escarotomía hasta la pérdida de pulsos irreversibles

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, pregunta **84** (pág. 27) · solucionario pág. 40.

Clase 11.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

11.14 Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

4.01.5.013 Evaluación pre y post-operatoria — Derivar a especialista

También: Conceptos generales del pre y post operatorio · Concepto de paciente quirúrgico ambulatorio · Evaluación nutricional · Albúmina plasmática · Evaluacion nutricional subjetiva

LO QUE TE PREGUNTAN

- Capacidad funcional **≥ 4 METs** (subir 2 pisos de escaleras o caminar en subida) autoriza cirugía sin pruebas cardíacas.
- Betabloqueadores y estatinas se MANTIENEN rigurosamente hasta la mañana de la cirugía con sorbo de agua.
- IECAs y ARA-II se SUSPENDEN **24 horas** antes para evitar hipotensión refractaria a la inducción anestésica.
- Metformina se suspende **24-48 horas** antes para prevenir acidosis láctica intraoperatoria.
- AAS en prevención secundaria se mantiene en cirugía general; solo se suspende en neurocirugía y oftalmología posterior.

ALGORITMO · PREOPERATORIO: PRIMERO EL CORAZÓN, DESPUÉS CADA FÁRMACO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

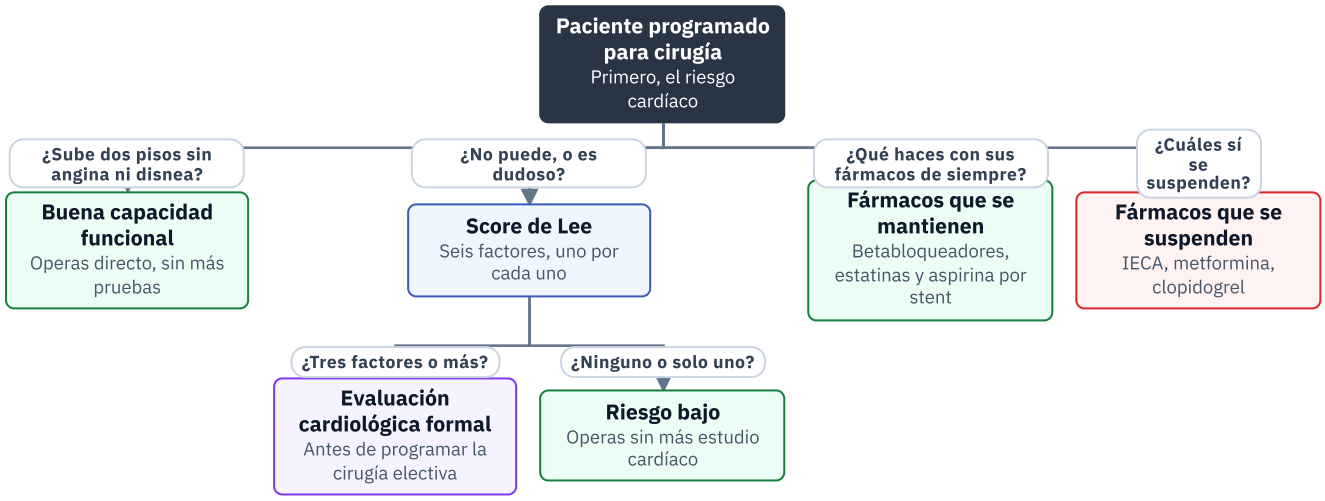


TABLA 11.14 · MANEJO PERIOPERATORIO DE FÁRMACOS CRÓNICOS MÁS FRECUENTES EN CIRUGÍA

GRUPO FARMACOLÓGICO	CONDUCTA PERIOPERATORIA EXACTA	MOMENTO DE SUSPENSIÓN / REINICIO	JUSTIFICACIÓN FISIOPATOLÓGICA
Betabloqueadores (Bisoprolol)	MANTENER con sorbo de agua la mañana de cx	No suspender; mantener en postoperatorio	Previene taquicardia refleja e isquemia miocárdica
IECAs / ARA-II (Losartán, Enalapril)	SUSPENDER 24 horas antes de la cirugía	Omitir la dosis de la mañana del pabellón	Evita hipotensión refractaria profunda en la inducción
Metformina	SUSPENDER 24 a 48 horas previas	Reiniciar al restablecer tolerancia y función renal	Previene acidosis láctica letal por hipoperfusión
AAS (Prevención secundaria)	MANTENER en cirugía general no neurológica	Solo suspender 7 días en neurocirugía/oftalmología	El riesgo de trombosis del stent supera el sangrado menor
Clopidogrel	SUSPENDER 5 a 7 días antes de la cirugía	Reiniciar a las 24-48 h postoperatorias según hemostasia	Inhibición plaquetaria irreversible con riesgo de hemorragia
Anticoagulantes orales directos (DOACs)	SUSPENDER 48 horas antes (sin terapia puente)	72 h antes si filtración glomerular < 30 mL/min	Vida media corta; el riesgo de sangrado es elevado

TRAMPAS EUNACOM

FÁRMACO	CONDUCTA	ERROR FRECUENTE
Betabloqueador de uso crónico	Mantener hasta la mañana de pabellón	Suspenderlo por prudencia
Aspirina por stent coronario	Mantener en cirugía general	Suspenderla como cualquier antiagregante
IECA la mañana de la cirugía	Omitir esa dosis	Darlo igual que todos los días

REGLA DE ORO **Sube dos pisos sin síntomas** — No necesita más estudio cardíaco

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cirugía General**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 11.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

11.15 Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

4.01.2.028 Intoxicación por anestésicos locales — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Conceptos básicos de anestesia general, local y regional · Anestesia local por infiltración · Manejo del dolor · Anestesia troncular de dedos y ortejos

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Dosis máxima de Lidocaína**: **4-5 mg/kg** SIN epinefrina (máx **300 mg**); **7 mg/kg** CON epinefrina (máx **500 mg**).
- **Dosis máxima de Bupivacaína**: **2 mg/kg** (máx **150 mg**); posee la mayor cardiotoxicidad de los anestésicos locales.
- **LAST inicia con pródromos neurológicos**: sabor metálico, parestesias periorales, tinnitus y diplopía.
- **Si progresa sin tratamiento**: convulsiones tónico-clónicas, coma, bloqueo AV, arritmias ventriculares y colapso cardiogénico.
- El antídoto específico indiscutido de la LAST es la EMULSIÓN LIPÍDICA AL **20%** (Intralipid): bolo **1.5 mL/kg** + infusión **0.25 mL/kg**/min.
- **En la RCP por LAST**: reducir las dosis de adrenalina (< **1 mcg**/kg) y EVITAR vasopresina, bloqueadores de calcio y betabloqueadores.
- La cefalea post-punción dural (CPPD) es postural; si es refractaria a reposo y cafeína, se trata con Parche Hemático Epidural.

ALGORITMO · TOXICIDAD POR ANESTÉSICOS LOCALES: EL SABOR METÁLICO MANDA A PARAR

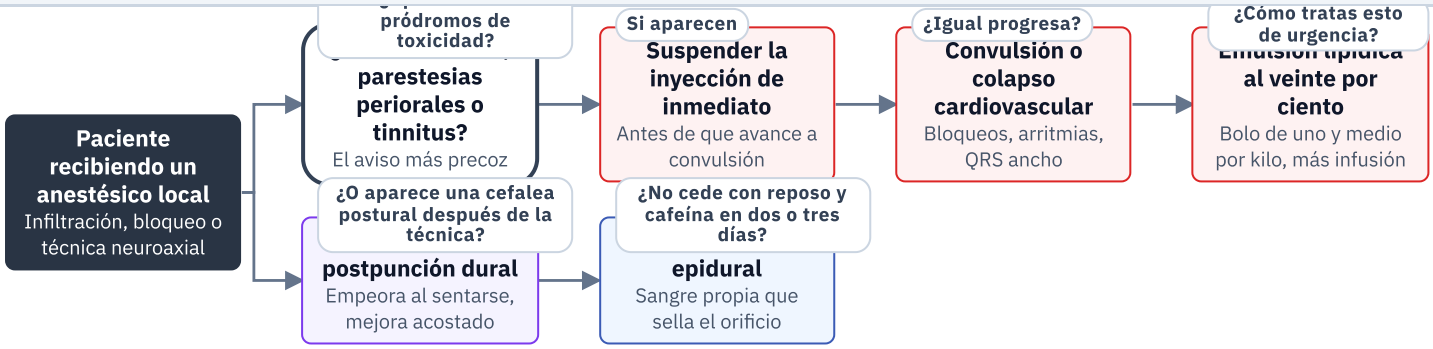


TABLA 11.15 · ANESTÉSICOS LOCALES TIPO AMIDA: DOSIS MÁXIMAS Y PERFIL FARMACOLÓGICO

FÁRMACO ANESTÉSICO	DOSIS MÁXIMA SIN EPINEFRINA	DOSIS MÁXIMA CON EPINEFRINA	COMIENZO Y DURACIÓN DE ACCIÓN
Lidocaína al 1% o 2%	4 – 5 mg/kg (Máximo 300 mg)	7 mg/kg (Máximo 500 mg)	Rápido (2-5 min); Duración intermedia (1-2 h sin epi, 3-4 h con epi)
Bupivacaína al 0.25% o 0.5%	2 mg/kg (Máximo 150 mg)	2.5 mg/kg (Máximo 175 mg)	Lento (10-15 min); Larga duración (4-8 h); ALTA CARDIOTOXICIDAD
Mepivacaína al 1% o 2%	4 – 5 mg/kg (Máximo 300 mg)	7 mg/kg (Máximo 500 mg)	Rápido; duración intermedia; menor vasodilatación propia
Ropivacaína al 0.5% o 0.75%	3 mg/kg (Máximo 200 mg)	3.5 mg/kg (Máximo 250 mg)	Lento; larga duración; menor cardiotoxicidad que bupivacaína

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Paciente en shock que necesita inducción	Etomidato	Propofol por costumbre
Sabor metálico y tinnitus durante un bloqueo	Suspender la inyección de inmediato	Terminar de pasar la dosis completa
Toxicidad sistémica por anestésico local	Emulsión lipídica al veinte por ciento	Solo soporte vital básico, sin antídoto
Cefalea postural tras raquídea	Reposo, hidratación y cafeína primero	Parche hemático de entrada

REGLA DE ORO **Shock o cardiopatía grave** — Etomidato en vez de propofol

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, pregunta **85** (pág. 27) · solucionario pág. 40.

Clase 11.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

11.16 Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)

★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

4.01.3.005 **Complicaciones postoperatorias frecuentes** — Conocimiento general

También: Proteína C reactiva · Hemorragia aguda post operatoria.

LO QUE TE PREGUNTAN

- La atelectasia pulmonar es la causa número 1 de fiebre en las primeras **24 a 48 horas** postoperatorias (Wind).
- El tratamiento de la atelectasia postquirúrgica es kinesiterapia respiratoria y deambulación precoz; NO requiere antibióticos.
- La infección del sitio quirúrgico suele manifestarse entre el 5° y 7° día postoperatorio (Wound); las infecciones antes de **48 h** son raras y sugieren S. pyogenes o Clostridium.
- La infección urinaria postoperatoria ocurre clásicamente hacia el día 3 (Water) y se previene retirando la sonda Foley lo antes posible.
- La sospecha de trombosis venosa profunda (Walking) exige Eco-Doppler de extremidades inferiores e inicio de anticoagulación con HBPM.
- Nunca se deben prescribir antibióticos a ciegas ante fiebre postoperatoria sin haber inspeccionado directamente la herida operatoria.



ATELECTASIA EN RX DE TÓRAX
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 3415

ALGORITMO · FIEBRE POSTOPERATORIA: EL DÍA DECIDE LA CAUSA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 11.16 · CRONOLOGÍA DE LA FIEBRE POSTOPERATORIA: REGLA DE LAS 5 'W'

MNEMOTECNIA	ETIOLOGÍA PRINCIPAL	DÍA POSTOPERATORIO HABITUAL	CLÍNICA CARDINAL	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
WIND	Atelectasia pulmonar	Día 1 a 2 (24-48 h)	Crepitaciones bibasales, taquipnea leve, herida limpia	Kinesiterapia respiratoria, analgesia, deambulación (No ATB)
WATER	Infección urinaria (ITU)	Día 3 a 5	Disuria, orina turbia, bacteriuria con sonda Foley	Retiro de catéter Foley + cultivo + antibiótico dirigido
WOUND	Infección sitio quirúrgico	Día 5 a 7 (tardía: hasta d30)	Eritema, calor, dolor en la herida, salida de pus	Apertura y drenaje de herida, aseo, curación abierta
WALKING	Trombosis venosa profunda	Día 7 a 10	Edema asimétrico de pantorrilla, dolor, signo de Homans	Eco-Doppler venoso + anticoagulación terapéutica (HBPM)
WONDER DRUGS	Fiebre medicamentosa	Día 7 o posterior	Paciente con buen estado general, eosinofilia, rash	Suspensión del fármaco desencadenante sospechoso

REGLA DE ORO **Wind, Water, Wound** — Días uno, tres y cinco a siete

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, pregunta **86** (pág. 27) · solucionario pág. 40.

Clase 11.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

11.17 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

4.01.3.016 Infección quirúrgica e intrahospitalaria — Conocimiento general

También: Hernias, eventraciones y evisceraciones · Antimicrobianos. Conceptos profilaxis y esquemas terapéuticos · Complicaciones postoperatorias frecuentes · Fístulas del intestino delgado · Asepsia y antisepsia · Ayudantía quirúrgica (nociones básicas) · Cultivo de heridas o abscesos

LO QUE TE PREGUNTAN

- La profilaxis antibiótica quirúrgica de elección en cirugía abdominal limpia-contaminada es Cefazolina **2 g** EV administrada **30-60 minutos** antes de la incisión.
- La salida de líquido serosanguinolento abundante en 'agua de carne' entre el 5° y 8° día es el signo cardinal de dehiscencia de fascia.
- Ante una evisceración aguda, NUNCA se deben reintroducir las asas en la sala; se deben cubrir con compresas estériles húmedas tibias y trasladar a pabellón.
- El pilar del tratamiento de la infección del sitio quirúrgico incisional es la apertura de la herida y el drenaje completo del pus.
- Los antibióticos sistémicos en una ISQ superficial solo están indicados si existe celulitis perilesional extensa (> **5 cm**) o signos de respuesta inflamatoria sistémica.



HERIDA ABIERTA, BORDES ROJOS
The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 674

ALGORITMO · HERIDA OPERATORIA: DE LA PREVENCIÓN A LA EVISCERACIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

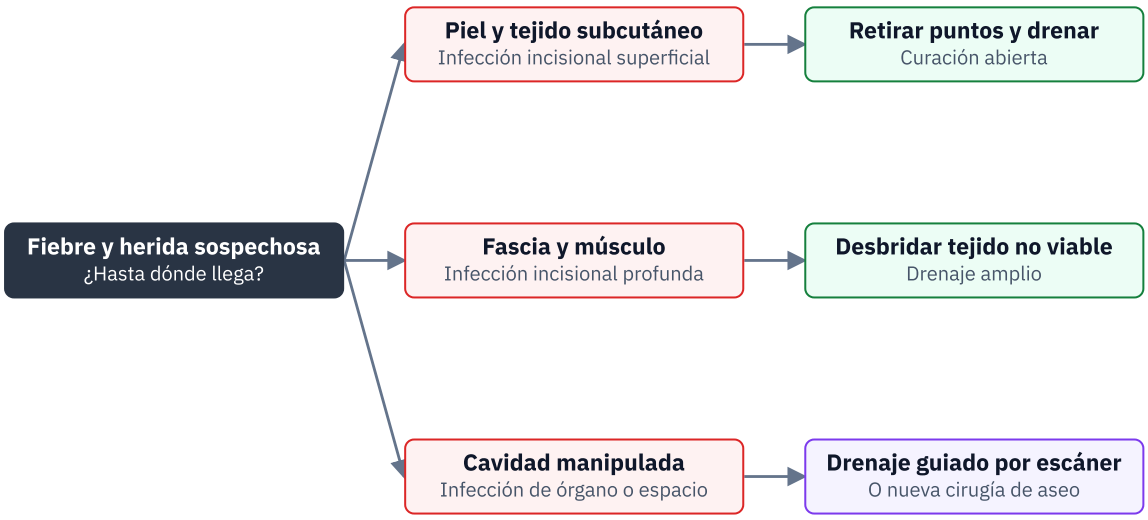


TABLA 11.17 · CLASIFICACIÓN DE INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO (CDC / MINSAL)

TIPO DE ISQ	LÍMITES ANATÓMICOS	CRITERIOS DIAGNÓSTICOS	MANEJO QUIRÚRGICO
ISQ Incisional Superficial	Compromete solo piel y tejido celular subcutáneo	Secreción purulenta, eritema, calor, dolor local (< 30 días)	Retiro de puntos, apertura de piel y tejido celular, curación húmeda
ISQ Incisional Profunda	Compromete fascia muscular y planos musculares	Drenaje purulento profundo, dehiscencia de fascia, fiebre	Apertura amplia, desbridamiento de tejido desvitalizado, drenaje
ISQ de Órgano / Espacio	Cualquier zona anatómica abierta o manipulada (peritoneo)	Absceso intraabdominal en TAC, peritonitis postoperatoria	Drenaje percutáneo guiado por TAC/eco o relaparotomía de aseo
Evisceración Aguda	Apertura de todos los planos con exteriorización visceral	Protrusión visible de asas o epiplón a través de la herida	Compresas estériles húmedas tibias + reparación quirúrgica urgente en pabellón

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

SITUACIÓN	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Colecistectomía electiva	Cefazolina 30 a 60 minutos antes	Darla después de cerrar la piel
Hernioplastía con malla	Sí lleva profilaxis, aunque sea limpia	Omitirla por ser cirugía limpia
Infección superficial de la herida	Abrir y drenar	Partir con antibióticos sin drenar

REGLA DE ORO **Cefazolina en limpia contaminada** — Treinta a sesenta minutos antes

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Cirugía General**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 11.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

11.18 Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

4.01.3.018 Tratamiento antitetánico y antirrábico — Conocimiento general

También: Mordeduras de animales · Heridas y contusiones menores · Curación de heridas, sutura y aseo · Cicatrices viciosas · Heridas de cara · Hemostasia con ligaduras y taponamiento de heridas sangrantes · Heridas de la mano no complicadas

LO QUE TE PREGUNTAN

- En heridas sucias o tetanígenas con vacunación desconocida o < 3 dosis, se debe administrar obligatoriamente Vacuna dT + Inmunoglobulina Antitetánica (TIG **250 UI**).
- Si el paciente tiene vacunación completa (**≥ 3 dosis**), NUNCA requiere inmunoglobulina; solo requiere refuerzo vacunal si pasaron > **5 años** en heridas sucias o > **10 años** en limpias.
- Las mordeduras de animales y humanas NO deben suturarse de regla; se manejan abiertas con aseo masivo a presión para evitar flemones y abscesos.
- El antibiótico de primera elección indiscutido para mordeduras de perro, gato o humanas es Amoxicilina / Ácido Clavulánico (cubre Pasteurella y Eikenella).
- Las mordeduras por murciélagos o animales silvestres carnívoros constituyen indicación formal de profilaxis antirrábica inmediata sin esperar observación del animal.
- En heridas faciales por mordedura se puede realizar sutura laxa exclusivamente por razones estéticas tras lavado quirúrgico profuso bajo cobertura antibiótica estricta.



MORDEDURA DE GATO INFECTADA
Open-i (NLM), CC BY

ALGORITMO · HERIDA TRAUMÁTICA: VACUNA, INMUNOGLOBULINA, O AMBAS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

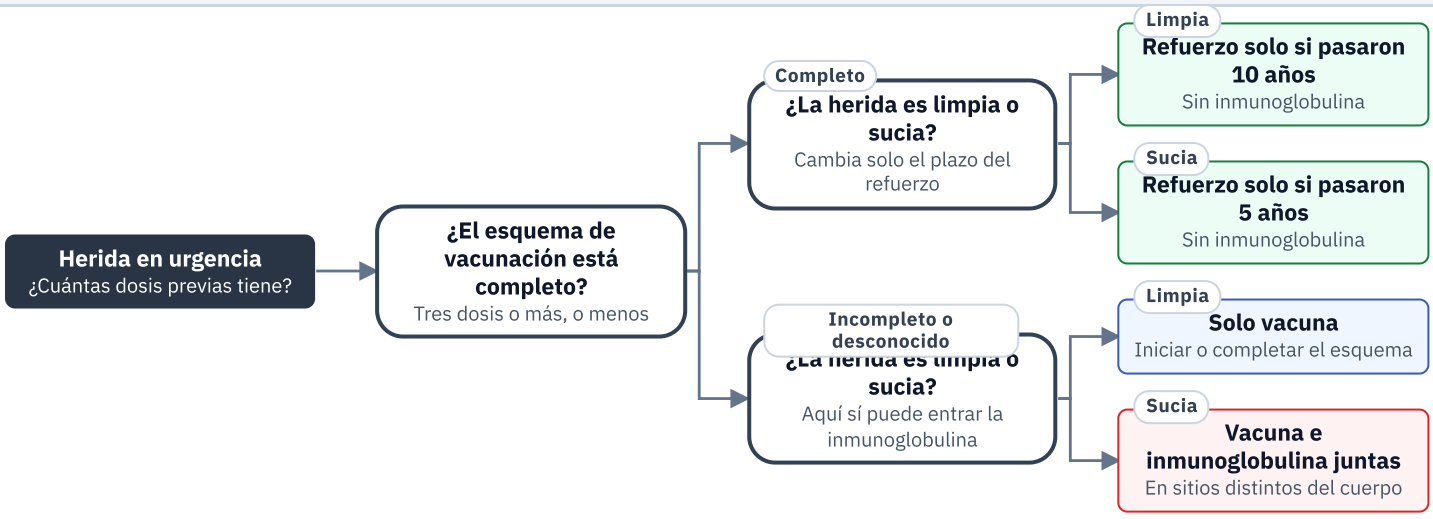


TABLA 11.18 · GUÍA DE PROFILAXIS ANTITETÁNICA SEGÚN ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN Y TIPO DE HERIDA

HISTORIA DE VACUNACIÓN PREVIA	HERIDA LIMPIA Y MENOR: VACUNA (DT)	HERIDA LIMPIA Y MENOR: TIG (250 UI)	HERIDA SUCIA / TETANÍGENA: VACUNA (DT)	HERIDA SUCIA / TETANÍGENA: TIG (250 UI)
Incierta o < 3 dosis	SÍ (iniciar esquema)	NO	SÍ (iniciar esquema)	SÍ (250 UI IM en otro sitio)
≥ 3 dosis (última < 5 años)	NO	NO	NO	NO
≥ 3 dosis (última hace 5 a 10 años)	NO	NO	SÍ (refuerzo con dT)	NO
≥ 3 dosis (última hace > 10 años)	SÍ (refuerzo con dT)	NO	SÍ (refuerzo con dT)	NO

REGLA DE ORO **Dosis previas y tipo de herida** — Esas dos variables lo definen

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, preguntas **77, 87–88** (págs. 26–27) · solucionario págs. 39–41.

Clase 11.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

11.21 Procedimientos de Cirugía Menor: Punción Venosa, Manejo de Drenajes, Onicocriptosis & Onicectomía

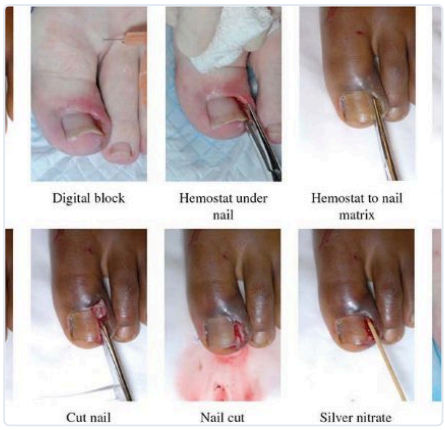
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.01.5.008
4.01.5.027 **Punción venosa** — Realizar

También: Manejo de drenajes · Onicocriptosis · Onicectomía

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Punción venosa**: torniquete por menos de **1 minuto**, nunca en el brazo con mastectomía y disección axilar, y nunca reencapuchar la aguja.
- En un drenaje se registra el débito y su aspecto; se retira cuando es seroso y menor de **30-50 mL** al día.
- Una gastrostomía madura (más de **4 semanas**) cuya sonda se sale se repone de inmediato por el ostoma tras verificar su posición.
- **Onicocriptosis estadio I**: baños, elevar el borde de la uña y calzado amplio; estadios II-III: onicectomía parcial con matricectomía con fenol.
- El bloqueo digital se hace con lidocaína sin adrenalina, **1 a 2 mL** en la base a cada lado del dedo.



ONICECTOMÍA PARCIAL
The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 361

ALGORITMO · UÑA ENCARNADA (ONICOCRIPTOSIS)

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

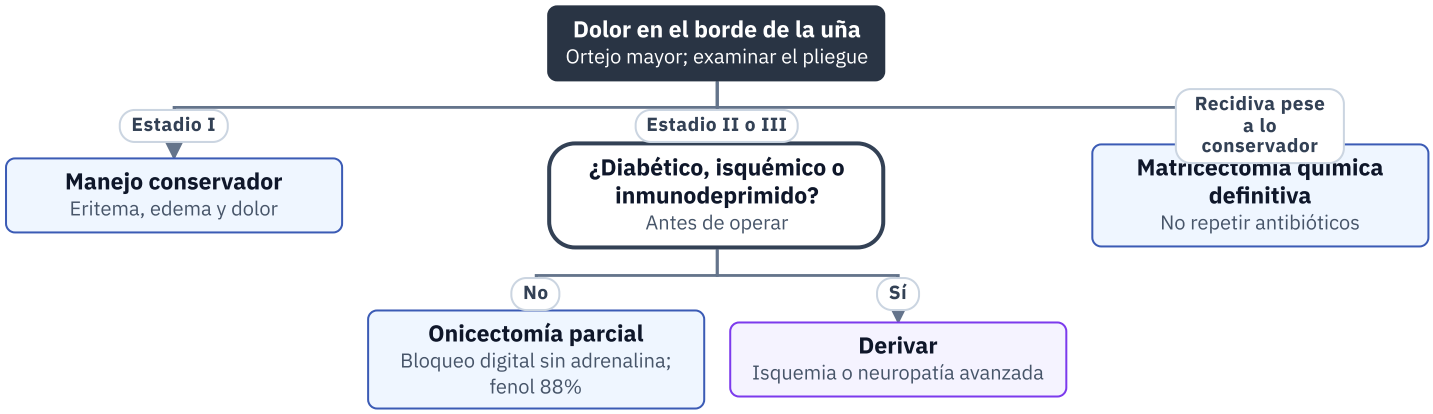


TABLA 11.21 · ONICOCRIPTOSIS: ESTADIOS DE HEIFETZ Y CONDUCTA

ESTADIO	HALLAZGO	CONDUCTA
I	Eritema, edema leve y dolor al presionar	Baños tibios, elevar el borde, corte recto, calzado amplio
II	Supuración, celulitis del pliegue	Onicectomía parcial + antibiótico si hay celulitis
III	Tejido de granulación hipertrófico	Onicectomía parcial + matricectomía con fenol
Recidivante	Episodios repetidos pese al manejo conservador	Matricectomía química definitiva

TRAMPAS EUNACOM

SITUACIÓN	ERROR	CONDUCTA CORRECTA
Torniquete	Dejarlo más de 1 minuto	Máximo 1 minuto; soltarlo antes de retirar la aguja
Mastectomía con disección axilar	Puncionar ese brazo	Usar el brazo contralateral
Aguja usada	Reencapucharla	Descartar directo en el contenedor
Hemostasia	Flexionar el brazo sobre la gasa	Comprimir con el brazo extendido 2-3 minutos
Punción arterial accidental	Presionar poco	Compresión firme de 5 minutos o más

REGLA DE ORO **Torniquete < 1 minuto** — Nunca en el brazo con mastectomía y disección axilar

PRACTICA **Libro Gordo Cirugía General**, pregunta **44** (pág. 20) · solucionario pág. 35.

Clase 11.21 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 21 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO	
11.1 Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	pág. 3
Plastrón: antibióticos primero — Cirugía electiva en **8 a 12 semanas**	TIEMPO
11.2 Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	pág. 5
Pared sobre **4 mm** — Más líquido perivesicular	CORTE
Grado I y II: operar pronto — Antes de **72 horas**	TIEMPO
Dolor postprandial — Brusco, de **30 minutos** a **6 horas**	TIEMPO
11.3 Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx	pág. 6
A los **3 a 6 meses** — Con estudio del segmento excluido	TIEMPO
Descartar cáncer de colon — Hasta **5%** son cáncer disfrazado	CORTE
11.4 Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	pág. 7
Ciego sobre **10 a 12 cm** — Riesgo inminente de perforación diastásica	CORTE
11.5 Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)	pág. 9
Suspender AINE y tabaco — IBP por **4 a 8 semanas**	TIEMPO
IBP + amoxicilina + claritromicina — **1 g** y **500 mg**, cada **12 horas**	DOSIS
Úlcera: erradicar H. pylori — IBP más dos antibióticos por **14 días**	TIEMPO
Helicobacter pylori — **90 %** de las duodenales, **70 %** de las gástricas	CORTE
BLOQUE 02 · PARED ABDOMINAL, HERNIAS & PROCTOLOGÍA	
11.6 Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	pág. 10
Niño: se cierra sola — Hasta los **4 a 5 años**	CORTE
Malla libre de tensión — Recidiva menor al **2 %**	CORTE
11.7 Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	pág. 11
Más del **90 %** ahí — Es la zona con menos irrigación	CORTE
Alarma o más de **45 años** — Rectosigmoidoscopía o colonoscopía	CORTE
11.19 Patología Vascular Periférica: Aneurismas, Várices e Insuficiencia Venosa & Úlceras de las Piernas	pág. 13
Nunca comprimir sin ITB — Contraindicado si ITB < 0,8	CORTE
Venosa: compresión multicapa — **30-40 mmHg**, solo si ITB > 0,8	CORTE
Piel fría y pálida, sin pulsos — ITB < 0,9; claudicación previa	CORTE
11.20 Obesidad Mórbida y Cirugía Bariátrica: Indicaciones, Técnicas y Complicaciones	pág. 15
IMC **≥ 40, o ≥ 35 con** comorbilidad — DM2, hipertensión, apnea	CORTE
IMC **≥ 40, o ≥ 35 con** comorbilidad — Y fracaso de **6 meses** de manejo médico	CORTE
BLOQUE 03 · POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)	
11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	pág. 16
Rojo: FR > 30, llene > 2 s — O no obedece órdenes simples	CORTE
Menores de **12 años** — Punción con aguja gruesa	CORTE
Collar, tabla, traslado en bloque — PAM sobre **85 mmHg**	CORTE
Alineación, huesos, espacios, partes blandas — Prevertebral > **7 mm** en C2 o **21 mm** en C6	CORTE
11.10 Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante	pág. 17
Sin fuga, pulmón expandido — Débito menor de **100 a 200 mL** al día	DOSIS
Incisión de **2 a 3 cm** — Por encima de la costilla inferior	CORTE
Conectar a sello de agua — Aspiración de **20 cm** de agua si hay fuga	CORTE

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
11.11 Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	pág. 19
Profilaxis de trombosis — Enoxaparina a las **24 a 48 horas**	TIEMPO
Intraperitoneal: cirugía — Extraperitoneal: sonda **10 a 14 días**	TIEMPO
11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC	pág. 21
Observar **4 a 6 horas** — Controles neurológicos seriados	TIEMPO
Clasificación de severidad según Escala de Glasgow: Leve (13-15), Moderado (9-12), Grave (**≤ 8 puntos**).	CORTE
Fractura de base, **65 años**, anticoagulado — O vómitos repetidos y mecanismo de alta energía	CORTE
11.13 Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES	pág. 22
Meta de diuresis horaria: **0.5 a 1.0 mL/kg**/h en adultos y **1.0 a 1.5 mL/kg**/h en niños.	DOSIS
Fórmula de Parkland: **4 mL** x kg x % SCQ (2° y 3° grado) de Ringer Lactato en **24 horas**.	DOSIS
Eritema máximo a las **24 a 36 horas** — Con flictenas ya es segundo grado superficial	TIEMPO
BLOQUE 04 · PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS	
11.14 Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios	pág. 24
Normal **3,5 a 5 g/dL** — Refleja las semanas previas, no lo agudo	DOSIS
Menos de **3 a 3,5 g/dL** — Más infección, dehiscencia, estadía y mortalidad	DOSIS
11.15 Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales	pág. 25
Paracetamol más AINE — Paracetamol **1 g** cada **6-8 h**; ketorolaco no más de **5 días**	DOSIS
Base del dedo, a cada lado — **1 a 2 mL** de lidocaína **1-2 %** sin adrenalina por lado	DOSIS
11.16 Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)	pág. 26
Sube a las **6 horas** — Máximo a las **36 a 50 horas**	TIEMPO
Precoz o tardía — Primeras **24 horas**, o días después	TIEMPO
Sube normal hasta el día 2 o 3 — En cirugía mayor llega a **100-150 mg**/L	DOSIS
11.17 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda	pág. 27
Normotermia y glicemia — Glicemia menor de **180 mg/dL**	DOSIS
Dentro de **30 días** — **90 días** si hay implante	TIEMPO
11.18 Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	pág. 28
Cara: **3 a 5 días** — Cuero cabelludo: **7 días**	TIEMPO
Presión directa **10 a 15 minutos** — Y elevar el miembro	TIEMPO
Tronco: **7 a 10 días** — Extremidades y manos: **10 a 14 días**	TIEMPO
11.21 Procedimientos de Cirugía Menor: Punción Venosa, Manejo de Drenajes, Onicocriptosis & Onicectomía	pág. 29
Débito < **30-50 mL** en **24 h** — Seroso y sin infección	DOSIS
Matricectomía con fenol al **88%** — 3 aplicaciones de 30 segundos; recidiva < **5%**	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
11.1 Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía			pág. 3
Cirugía y antibióticos · No complicada	**Cefazolina más metronidazol**	Una sola dosis antes de la incisión	
11.3 Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx			pág. 6
Hospitalizado	**Ceftriaxona más metronidazol EV**	Al menos **3 a 5 días** endovenoso	
11.5 Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)			pág. 9
Base del tratamiento · Suspender AINE y tabaco	**IBP por 4 a 8 semanas**		
Si hay H. pylori	**IBP + amoxicilina + claritromicina**	**1 g** y **500 mg**, cada **12 horas**	
Si hay H. pylori	**Cuádruple con bismuto**	Alergia a penicilina o fracaso	
11.8 Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas			pág. 12
Tratamiento escalonado	**Doxiciclina o clinda-rifampicina**	En los brotes	
11.19 Patología Vascular Periférica: Aneurismas, Várices e Insuficiencia Venosa & Úlceras de las Piernas			pág. 13
Pulsos e ITB antes de comprimir · Según el origen	**Revascularización, antiagregante y estatina**		
11.20 Obesidad Mórbida y Cirugía Bariátrica: Indicaciones, Técnicas y Complicaciones			pág. 15
Suplementos de por vida · Control de por vida	**Multivitamínico, calcio con D, B12 y hierro**	De por vida	
11.10 Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante			pág. 17
Ambulatorio si no hay riesgo · Analgesia multimodal	**Paracetamol más AINE; opioide o bloqueo si hace falta**		
Ambulatorio si no hay riesgo	**Kinesiterapia y tos asistida**	Vendaje compresivo contraindicado	
11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC			pág. 21
Neurocirugía urgente · TAC; punción lumbar contraindicada	**Hematomas, tumores, hidrocefalia, abscesos, meningitis**		
11.13 Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES			pág. 22
Prevención y tratamiento	**Corticoide intralesional**	Para hipertróficas y queloides; derivar a plástica	
11.15 Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales			pág. 25
El antídoto	**Midazolam para la convulsión**	Evita propofol si ya está hipotenso	
Analgesia horaria y multimodal · Si persiste	**Opioide débil, luego fuerte**	Tramadol; morfina titulada	
11.21 Procedimientos de Cirugía Menor: Punción Venosa, Manejo de Drenajes, Onicocriptosis & Onicectomía			pág. 29
Tubos y seguridad · Orden: hemocultivos, celeste, rojo, verde, lila, gris	**Citrato, suero, heparina, EDTA, fluoruro**		

GES de Cirugía General y Anestesia

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

Fármacos de primera línea · continuación

GES **GES N° 24: Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula biliar en personas de 35 a 49 años sintomáticas · En colecistitis aguda la intervención es una urgencia médica y quirúrgica preferente.**

Tema **11.2** · Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap
`4.01.2.011` · `4.01.1.027` · `4.01.4.011`
pág. **5**

GES **GES N° 58: Tratamiento quirúrgico de hernia del desarrollo de la pared abdominal en personas menores de 15 años · En adultos la reparación electiva previene el atascamiento y la estrangulación de urgencia.**

Tema **11.6** · Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones
`4.01.1.021` · `2.01.1.090`
pág. **10**

GES **GES N° 54: Politraumatizado Grave · Atención de urgencia inmediata garantizada con acceso en menos de 24 horas a centro de alta complejidad.**

Tema **11.9** · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)
`4.01.2.027` · `4.01.5.014` · `4.01.5.015`
pág. **16**

GES **Garantía GES Politraumatizado Grave (GES N° 54) · Procedimientos de rescate pleural y descompresión torácica inmediata cubiertos con garantía de urgencia vital.**

Tema **11.10** · Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante
`4.01.2.016` · `1.05.2.011` · `1.01.2.008`
pág. **17**

GES **Garantía GES Politraumatizado Grave (GES N° 54) · Acceso expedito a laparotomía exploradora de urgencia y soporte intensivo en trauma abdominal exanguinante.**

Tema **11.11** · Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia
`4.01.2.010` · `4.01.4.011` · `4.03.2.008`
pág. **19**

GES **GES N° 55: Traumatismo Cráneo Encefálico (TEC) moderado o grave · Confirmación diagnóstica con neuroimagen en menos de 2 horas e ingreso prioritario a UPC.**

Tema **11.12** · Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC
`1.10.2.019` · `1.10.2.020` · `1.10.4.001`
pág. **21**

GES **GES N° 56: Gran Quemado · Acceso a atención médica especializada de urgencia inmediata y traslado a centro de alta complejidad antes de 24 horas.**

Tema **11.13** · Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES
`4.01.2.026` · `4.01.5.008` · `4.01.1.056`
pág. **22**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Prevención y Profilaxis Post-exposición a Rabia y Tétanos · Notificación Obligatoria.**

Tema **11.18** · Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica
`4.01.3.018` · `1.04.3.002` · `4.01.2.025`
pág. **28**

Sin garantía GES específica (13 temas): 11.1 · 11.3 · 11.4 · 11.5 · 11.7 · 11.8 · 11.19 · 11.20 · 11.14 · 11.15 · 11.16 · 11.17 · 11.21. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

4 temas · ★★★

- ★★★ **11.4** Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer 7
- ★★★ **11.8** Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas 12
- ★★★ **11.5** Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo) 9
- ★★★ **11.10** Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante 17

Practica: Libro Gordo Cirugía General, preguntas 8–17, 32–36, 49–50, 52–53, 55, 66, 75.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **11.16** Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs) 26
- ★★★ **11.7** Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas 11
- ★★★ **11.9** Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) 16
- ★★☆ **11.2** Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap 5

Practica: Libro Gordo Cirugía General, preguntas 7, 24–31, 38, 43, 51, 54, 56, 61–62, 70, 72, 80, 82, 86, 90.

DÍA 3

4 temas · ★★

- ★★☆ **11.19** Patología Vascular Periférica: Aneurismas, Várices e Insuficiencia Venosa & Úlceras de las Piernas 13
- ★★☆ **11.11** Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia 19
- ★★☆ **11.13** Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES 22
- ★★☆ **11.1** Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía 3

Practica: Libro Gordo Cirugía General, preguntas 4, 6, 41–42, 46–48, 58, 65, 67–68, 76, 83–84.

DÍA 4

3 temas · ★★

- ★★☆ **11.6** Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones 10
- ★★☆ **11.12** Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC 21
- ★★☆ **11.18** Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica 28

Practica: Libro Gordo Cirugía General, preguntas 18, 22–23, 69, 77, 87–89.

DÍA 5

3 temas · ★

- ★☆☆ **11.3** Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx 6
- ★☆☆ **11.20** Obesidad Mórbida y Cirugía Bariátrica: Indicaciones, Técnicas y Complicaciones 15
- ★☆☆ **11.15** Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales 25

Practica: Libro Gordo Cirugía General, preguntas 45, 71, 73, 85.

DÍA 6

3 temas · ★

- ★☆☆ **11.17** Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda 27
- ★☆☆ **11.21** Procedimientos de Cirugía Menor: Punción Venosa, Manejo de Drenajes, Onicocriptosis & Onicectomía 29
- ★☆☆ **11.14** Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios 24

Practica: Libro Gordo Cirugía General, preguntas 44.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 30
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 11.4 · 11.5 · 11.7 · 11.8 · 11.9 · 11.10 · 11.16
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Cirugía General en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 7 temas

13 11.4. Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer 7
13 11.8. Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas 12
12 11.5. Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo) 9
9 11.10. Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante GES 17
7 11.16. Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs) 26
6 11.7. Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas 11
5 11.9. Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) GES 16

★★ Prioridad media · 8 temas

3 11.2. Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap GES 5
3 11.19. Patología Vascular Periférica: Aneurismas, Várices e Insuficiencia Venosa & Úlceras de las Piernas 13
3 11.11. Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia GES 19
3 11.13. Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES GES 22
2 11.1. Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía 3
2 11.6. Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones GES 10
2 11.12. Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC GES 21
2 11.18. Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica GES 28

★ Prioridad baja · 6 temas

1 11.3. Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx 6
1 11.20. Obesidad Mórbida y Cirugía Bariátrica: Indicaciones, Técnicas y Complicaciones 15
1 11.15. Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales 25
1 11.17. Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda 27
1 11.21. Procedimientos de Cirugía Menor: Punción Venosa, Manejo de Drenajes, Onicocriptosis & Onicectomía 29
0 11.14. Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios 24